



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN
KOMITE PENGENDALIAN RESISTENSI
ANTIMIKROBA
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
MALANG**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
2.6 STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT	4
3.1. SDM	6
3.1.1. Ketenagaan (distribusi tenaga, kualifikasi dan kebutuhan).....	6
3.1.2. Orientasi.....	6
3.2. Pengembangan Pelayanan.....	6
3.3. Kegiatan PPRA.....	6
3.4. Kinerja Produktivitas	7
3.4.1. Surveilans penggunaan antibiotik.....	7
3.5. Kuantitas Penggunaan Antibiotik DDD.....	8
3.5.1. SMF Bedah.....	8
3.5.2. SMF Obgyn.....	10
3.5.3. SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung	12
3.6. Kuantitas Penggunaan Antibiotik DDD TW I	15
3.6.1. SMF Bedah.....	15
3.6.2. SMF Obgyn.....	16
3.6.3. SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung	16
3.7. Kuantitas Penggunaan Antibiotik DDD TW II	17
3.7.1. SMF Bedah.....	17
3.7.2. SMF Obgyn.....	18
3.7.3. SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung	19
3.8. Kuantitas Penggunaan Antibiotik DDD TW III	20
3.8.1. SMF Bedah.....	20
3.8.2. SMF Obgyn.....	21
3.8.3. SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung	22
3.9. Kuantitas Penggunaan Antibiotik DDD TW IV	23
3.9.1. SMF Bedah.....	23
3.9.2. SMF Obgyn.....	24
3.9.3. SMF IPD, Paru, Syaraf, Jantung	25
3.10. Kualitas Penggunaan Antibiotik (Gyssens)	27
3.10.1. SMF Bedah.....	27

3.10.2.SMF Obgyn.....	29
3.10.3.SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung	32
3.10.4.SMF Anak	35
3.11. Kualitas Penggunaan Antibiotik (Gyssens) TW I	38
3.11.1.SMF Bedah.....	38
3.11.2.SMF Obgyn.....	39
3.11.3.SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung	39
3.12. Kualitas Penggunaan Antibiotik (Gyssens) TW II	40
3.12.1.SMF Bedah	40
3.12.2.SMF Obgyn.....	42
3.12.3.SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung	42
3.13. Kualitas Penggunaan Antibiotik (Gyssens) TW III	43
3.13.1.SMF Bedah.....	43
3.13.2.SMF Obgyn.....	44
3.13.3.SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung	45
3.13.4.SMF Anak	46
3.14. Kualitas Penggunaan Antibiotik (Gyssens) TW IV	47
3.14.1.SMF Bedah.....	47
3.14.2.SMF Obgyn.....	48
3.14.3.SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung	49
3.14.4.SMF Anak	50
6 POLA MIKROBA DAN KEPEKAAN ANTIMIKROBA	52
8.1 Spesimen Darah – Jenis Bakteri Gram Negatif.....	52
8.2. Spesimen Darah – Jenis Bakteri Gram Positif	53
8.3 Spesimen Sputum – Jenis Bakteri Gram Negatif.....	54
8.4 Spesimen Sputum – Jenis Bakteri Gram Positif.....	55
8.5 Spesimen Urine – Jenis Bakteri Gram Negatif.....	56
8.6 Spesimen Urine – Jenis Bakteri Gram Positif.....	57
8.7 Spesimen Pus – Jenis Bakteri Gram Negatif.....	58
8.8 Spesimen Pus – Jenis Bakteri Gram Positif	59
8.9 Spesimen Feses – Jenis Bakteri Gram Negatif.....	60
7 KEGIATAN BELUM TERLAKSANA DAN TINDAK LANJUT	61
8 KESIMPULAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Program Kerja Komite PPRA **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Bedah TW I Tahun 2025 15

Tabel 3. Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Obgyn TW I Tahun 2025 16

Tabel 4. Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung TW I 2025 16

Tabel 5. Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Bedah TW II 2025 17

Tabel 6. Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Obgyn TW II 2025 18

Tabel 7. Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Obgyn TW II 2025 19

Tabel 8. Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Bedah TW III 2025 20

Tabel 9. Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Obgyn TW III 2025 21

Tabel 10. Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung TW III 2025 22

Tabel 11. Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Bedah TW IV 2025 23

Tabel 12. Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Obgyn TW IV 2025 24

Tabel 13. Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung TW IV 2025 25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Bedah TW I	16
Gambar 2. Grafik Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Obgyn TW I	16
Gambar 3. Grafik Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung TW I	17
Gambar 4. Grafik Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Bedah TW II	18
Gambar 5. Grafik Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Obgyn TW II	19
Gambar 6. Grafik Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung TW III	20
Gambar 7. Grafik Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Bedah TW III	21
Gambar 8. Grafik Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Obgyn TW III	22
Gambar 9. Grafik Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF IPD, Paru, Syaraf, Jantung TW III	23
Gambar 10. Grafik Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Bedah TW III	24
Gambar 11. Grafik Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Obgyn TW IV	25
Gambar 12. Grafik Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF IPD, Paru, Syaraf, Jantung TW V	26

LAPORAN KINERJA TAHUNAN KOMITE PPRA RS PRIMA HUSADA MALANG TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit sebagai salah satu sub sistem pelayanan kesehatan memberikan dua jenis pelayanan kepada masyarakat yaitu pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi. Pelayanan kesehatan mencakup pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, rehabilitasi medik dan pelayanan perawatan. Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui unit gawat darurat, unit rawat jalan, dan unit rawat inap.

Dalam perkembangannya pelayanan rumah sakit tidak terlepas dari pembangunan ekonomi masyarakat. Perkembangan ini tercermin pada perubahan fungsi klasik RS yang pada awalnya hanya memberi pelayanan yang bersifat penyembuhan (kuratif) terhadap pasien. Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat, rumah sakit pun semakin meningkatkan pelayanannya. Pelayanan rumah sakit saat ini tidak hanya bersifat kuratif (penyembuhan) tetapi juga bersifat rehabilitatif (pemulihan) yang dilaksanakan secara terpadu melalui upaya promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif).

Program Pengendali Resistensi Antibiotik (PPRA) merupakan kepanitiaan di rumah sakit yang berperan dalam menetapkan kebijakan penggunaan antibiotik, pencegahan dan penyebaran bakteri yang resisten serta pengendalian resistensi bakteri terhadap antibiotik. Pada setiap kepanitiaan tersebut, apoteker berperan penting dalam meningkatkan penggunaan antibiotik yang bijak.

Penyakit infeksi di Indonesia masih termasuk dalam sepuluh penyakit terbanyak. Peresep-an antibiotik di Indonesia yang cukup tinggi dan kurang bijak akan meningkatkan kejadian resistensi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa telah muncul mikroba yang resisten antara lain *Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus* (MRSA), resistensi multi obat pada penyakit tuberkulosis (MDR-TB) dan lain-lain. Dampak resistensi terhadap antibiotik adalah meningkatnya morbiditas, mortalitas dan biaya kesehatan.

Di rumah sakit, penggunaan antibiotik yang tidak perlu atau berlebihan mendorong berkembangnya resistensi dan multiple resisten terhadap bakteri tertentu yang akan menyebar melalui infeksi silang. Terdapat hubungan antara penggunaan (atau kesalahan penggunaan antibiotik dengan timbulnya resistensi bakteripenyebab infeksi nosokomial. Resistensi tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat diperlambat melalui penggunaan antibiotik yang bijak. Hal tersebut membutuhkan kebijakan dan program pengendalian antibiotik yang efektif.

Penggunaan antibiotik yang terkendali dapat mencegah munculnya resistensi antimikroba dan menghemat penggunaan antibiotik yang pada akhirnya akan mengurangi beban biaya perawatan pasien, mempersingkat lama perawatan, penghematan bagi rumah sakit serta meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit. Selain itu, penggunaan antibiotik yang tidak tepat oleh pasien meliputi: ketidak patuhan pada regimen terapi dan swamedikasi antibiotik dapat memicu terjadinya resistensi.

1.2 Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2406/ MENKES/ PER/ XII/ 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2406/ MENKES/ PER/ XII/ 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit

-
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Pedoman Penggunaan Antibiotik
 7. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1042.92/DPM/I-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.
 8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Tujuan Umum

1. Menggunakan antibiotik secara bijak dan rasional
2. Mencegah penyebaran mikroba resisten terhadap antibiotik

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan tentang penggunaan antibiotik secara bijak dan rasional
2. Meningkatkan pelayanan farmasi klinik dalam memantau penggunaan antibiotik
3. Melaksanakan surveilans pola penggunaan antibiotik
4. Melaksanakan surveilans pola mikroba dan kepekaan antibiotik

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Perkembangan Kelembagaan secara Historis

Berawal dari Praktek pribadi dr. Sadi Hariono, MMRS sebagai dokter umum sejak tahun 1990 di Banjararum Selatan No. 3B, kami telah mengabdikan diri melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Seiring dengan perkembangan penduduk dan peningkatan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang lebih luas, maka kamipun berupaya mengembangkan diri untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, sehingga mengantarkan kami pada berdirinya Rumah Sakit Prima Husada. Perjalanan Peningkatan Status Pelayanan:

Tahun 1990 – 2005	: Praktek Pribadi Dokter Umum
Tahun 2005 – 2009	: Balai Pengobatan Prima Husada
Agustus 2009	: Klinik Rawat Inap Layanan Medik Dasar
Mei 2010	: Menjadi Rumah Sakit Umum dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.Malang
Tahun 2010 – 2014	: Izin Operasional Rumah Sakit Sementara
Februari 2015	: Izin Operasional Rumah Sakit Tetap
Februari 2016	: Penetapan Rumah Sakit Tipe C
Maret 2016	: Akreditasi Paripurna
Desember 2016	: Penghargaan Rumah Sakit Trauma Center terbaik se Malang Raya Tahun 2016
April 2017	: Juara 1 Pelayanan dan Respon terbaik (Dinkes Kab. Malang)
Desember 2017	: Penghargaan Rumah Sakit Trauma Center terbaik se Jawa Timur Tahun 2017
Desember 2017	: Pengembangan Gedung DPM
Februari 2018	: Menjadi tempat dokter internsip
Desember 2022	: Akreditasi Paripurna

2.2 Visi

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.3 Misi

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

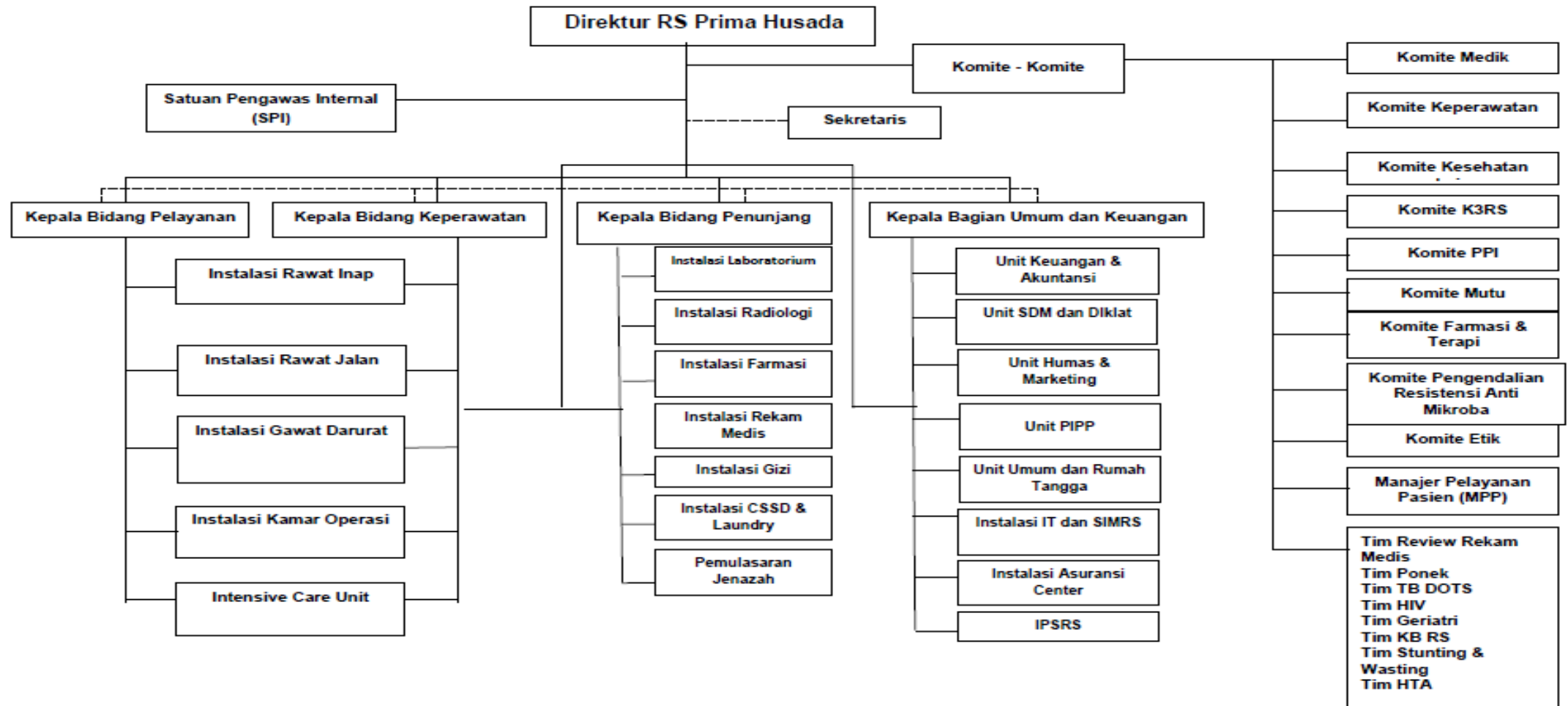
2.4 Motto

Sahabat Menuju Sehat

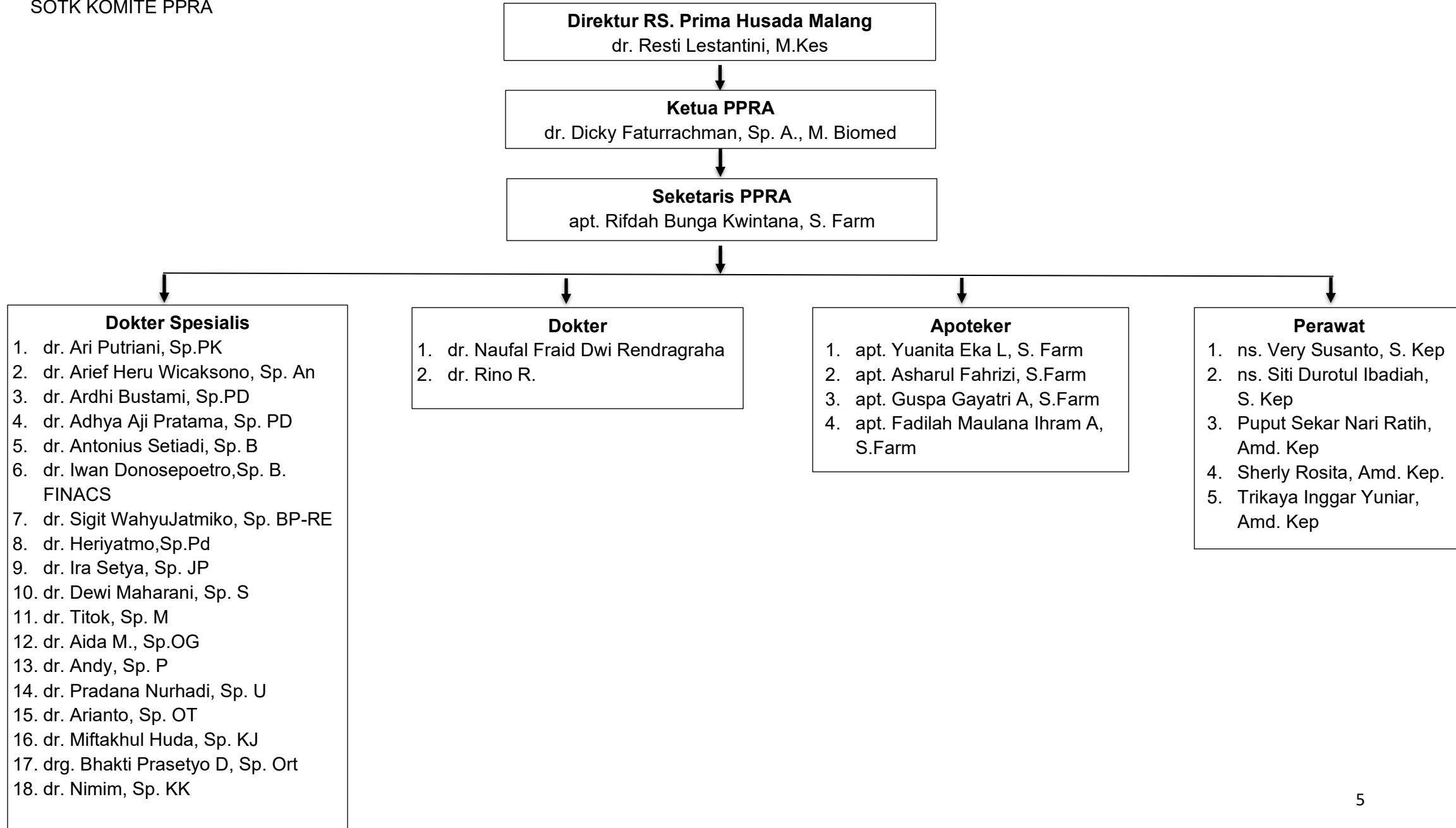
2.5 7 Nilai Budi Utama

1. Jujur
2. Tanggungjawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.6 STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT



SOTK KOMITE PPRA



BAB III.
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

3.1. SDM

3.1.1. Ketenagaan (distribusi tenaga, kualifikasi dan kebutuhan)

Tabel 1. Jumlah SDM tim PPRATahun 2025

Jabatan	Jumlah SDM												
	Standar	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
Ketua PPRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sekretaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Anggota	31	31	31	31	31	31	30	30	29	29	29	29	29

Analisis :

- a. Jumlah tim PPRA secara keseluruhan berjumlah 33 orang. Terdiri dari 1 ketua, 1 sekretaris dan 31 anggota.
- b. Kualifikasi anggota tim PPRA terdiri dari perwakilan dokter tiap SMF, perwakilan dokter IGD, seluruh apoteker rawat inap, dan perawat.
- c. Seluruh tim PPRA memiliki SIP, dan STR yang masih berlaku

Rencana Tindak Lanjut :
Melakukan pemenuhan kebutuhan anggota PPRA sesuai dengan kualifikasi

3.1.2. Orientasi
Pada tahun 2025 tidak ada orientasi.

3.2. Pengembangan Pelayanan
Menyelenggarakan forum kajian kasus terintegrasi (FORKKIT) secara rutin untuk peningkatan mutu penanganan tata laksana infeksi

3.3. Kegiatan PPRA
Tabel 2. Kegiatan PPRA 2025

Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan
Meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan tentang PPRA	1. Sosialisasi terkait penggunaan antibiotic secara bijak kepada PPA RS Prima Husada Malang 2. Sosialisasi tentang penggunaan antibiotik yang bijak serta program kerja PPRA kepada staff farmasi RS Prima Husada Malang 3. Sosialisasi tentang penggunaan antibiotic yang bijak kepada pasien dan keluarga pasien (rawat inap dan rawat jalan) 4. Sosialisasi penggunaan antibiotik yang bijak kepada masyarakat melalui media sosial RS Prima Husada Malang
Mengetahui panduan penggunaan antibiotik di RSPH	Sosialisasi panduan penggunaan antibiotik
Optimalisasi penggunaan antimikroba secara bijak melalui penerapan PGA (Penatagunaan Antimikroba)	1. Menerapkan sistem formularium antibiotik dan daftar antibiotik terbatas 2. Mewajibkan pengisian formulir PGA sebelum pemberian antibiotik tertentu

	3. Melakukan audit dan feedback berkala terkait pola persepsian antimikroba.
Memastikan pemakaian antibiotik di RSPH sesuai dengan panduan yang ditetapkan.	4. Melakukan pengumpulan data kuantitatif (DDD/100 bed days) dan kualitatif (audit ketepatan indikasi, dosis, durasi) 5. Menyusun laporan tren penggunaan antibiotik per bulan 6. Melakukan evaluasi kepatuhan penggunaan antibiotik sesuai panduan klinis

3.4. Kinerja Produktivitas

3.4.1. Surveilens penggunaan antibiotik

Tabel 3. Surveilens penggunaan antibiotik RSPHM tahun 2025

URAIAN	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
Penggunaan antibiotik	57,22	57,06	62,01	66,85	69,74	73,45	71,79	71,62	69,11	69,04	73,34	70,23

Analisis :

- a. Pengambilan data diambil dari SIMRS.
- b. Penggunaan antibiotik tertinggi pada bulan Juni sebesar 73,45 % dan yang paling rendah pada bulan januari 57,22 %.

Rencana tindak lanjut :

- a. Dilakukan sosialisasi masiv terkait penggunaan antibiotik bijak dan rasional terhadap DPJP.
- b. Dukungan manajemen melalui komite medis untuk melakukan supervisi terkait penggunaan antibiotik.

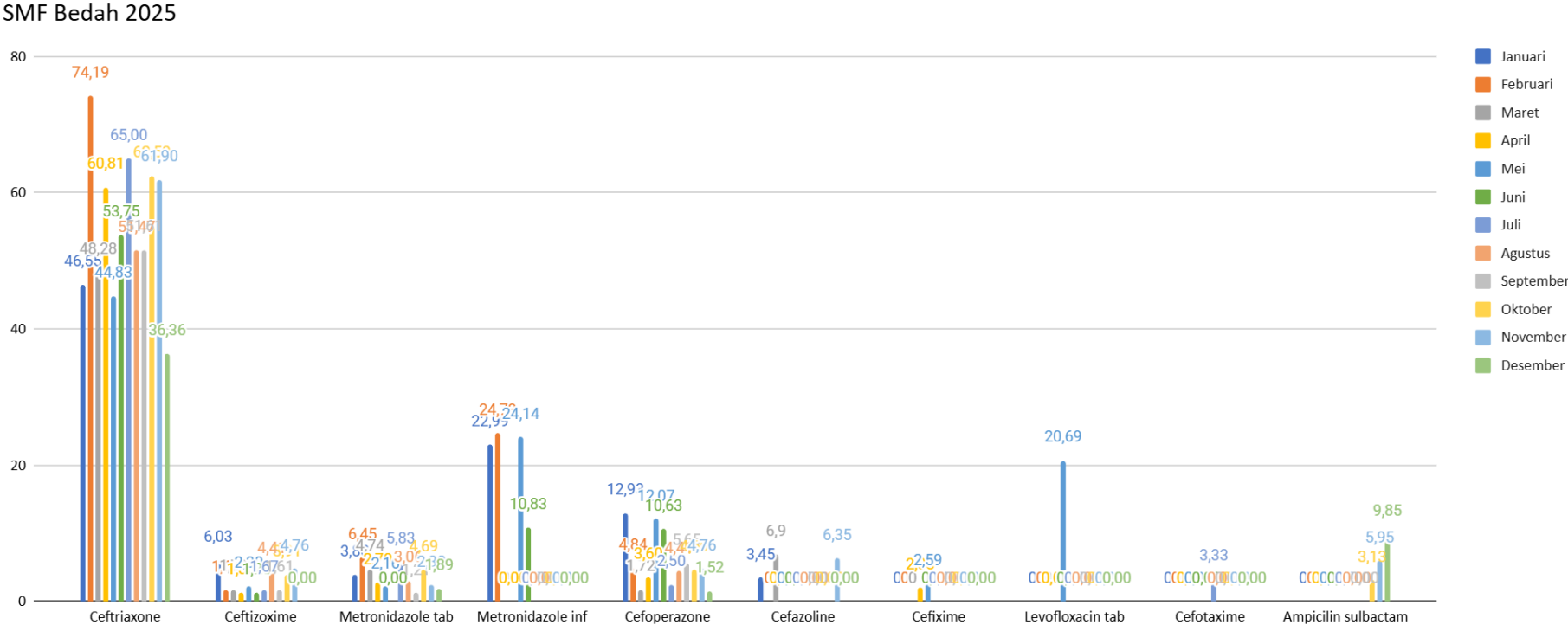
3.5. Kuantitas Penggunaan Antibiotik DDD

3.5.1. SMF Bedah

Table 4. Penggunaan antibiotik secara kuantitatif pada SMF Bedah

Nama Obat	Bulan (DDD/100)											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Ceftriaxone	46,55	74,19	48,28	60,81	44,83	53,75	65,00	51,47	51,61	62,50	61,90	36,36
Ceftizoxime	6,03	1,61	1,72	1,35	2,30	1,25	1,67	4,41	1,61	3,91	4,76	0
Metronidazole ta	3,88	6,45	4,74	2,70	2,16	0	5,83	3,06	1,21	4,69	2,38	1,89
Metronidazole inf	22,99	24,73	0	0	24,14	10,83	0	0	0	0	0	0
Cefoperazone	12,93	4,84	1,72	3,60	12,07	10,63	2,50	4,41	5,65	4,69	4,76	1,52
Cefazoline	3,45	0	6,9	0	0	0	0	0	0	0	6,35	0
Cefixime	0	0	0	2,03	2,59	0	0	0	0	0	0	0
Levofloxacin tab	0	0	0	0	20,69	0	0	0	0	0	0	0
Cefotaxime	0	0	0	0	0	0	3,33	0	0	0	0	0
Ampicillin sulbactam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,13	5,95	9,85

Gambar 1. Grafik Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Bedah



Analisis :

Penggunaan antibiotik pada tahun 2025 oleh SMF Bedah terdiri dari 10 antibiotik diantaranya Ceftriaxone, Ceftizoxime, Metronidazole tab, Metronidazole inf, Cefoperazone, Cefazoline, Cefixime, Levofloxacin tab, Cefotaxime dan Ampicillin Sulbactam. Antibiotik yang paling banyak digunakan oleh SMF bedah adalah

antibiotik Ceftriaxone. Nilai tertinggi terdapat di bulan Februari sebesar 74,19 DDD/100 hari rawat inap. Hasil tersebut dapat dikaitkan dengan pemberian Ceftriaxone sebagai terapi empiris pada kebanyakan diagnosis infeksi di RS Prima Husada Malang.

Rencana Tindak Lanjut :

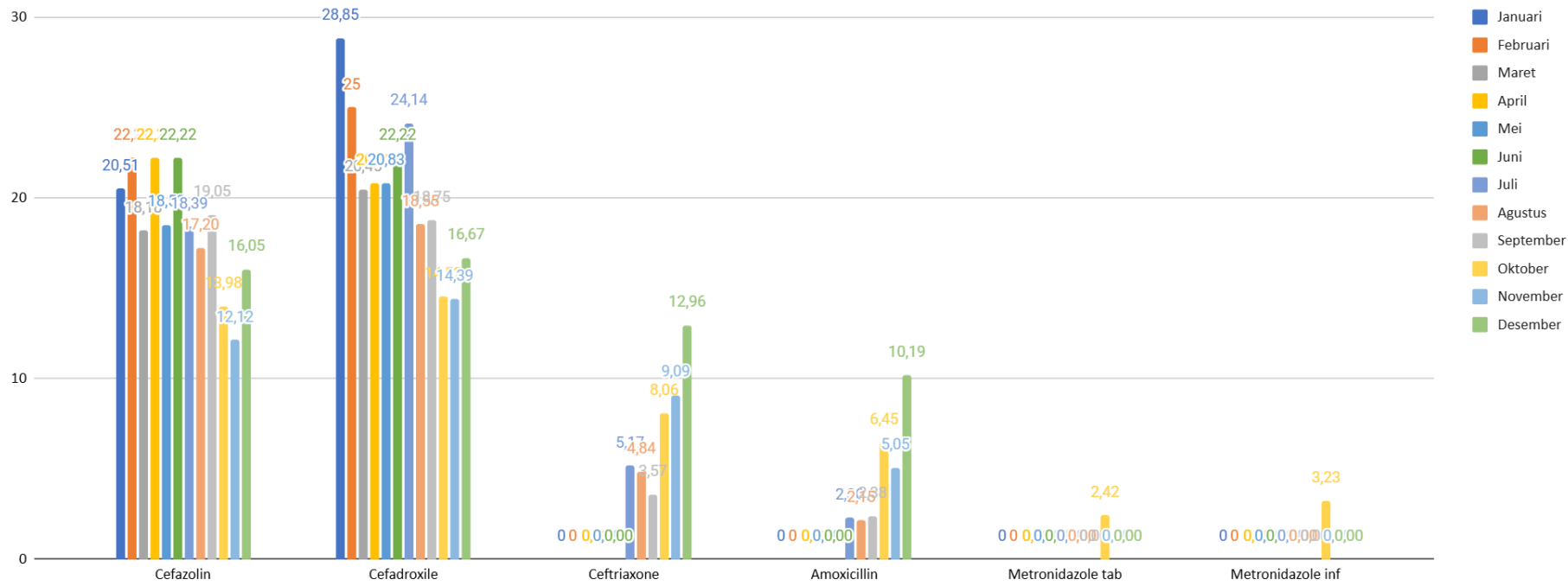
Pemberian antibiotik Ceftriaxone sebagai profilaksis pada SMF Bedah tahun 2025 masih termasuk cukup tinggi sehingga perlu dukungan manajemen melalui komite medis untuk melakukan supervisi dan sosialisasi terkait penggunaan antibiotik yang bijak dan rasional.

3.5.2. SMF Obgyn

Table 4. Penggunaan antibiotik secara kuantitatif pada SMF Obgyn

Nama Obat	Bulan (DDD/100)											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Cefazolin	20,51	22,22	18,18	22,22	18,52	22,22	18,39	17,20	19,05	13,98	12,12	16,05
Cefadroxile	28,85	25	20,45	20,83	20,83	22,22	24,14	18,55	18,75	14,52	14,39	16,67
Ceftriaxone	0	0	0	0	0	0	5,17	4,84	3,57	8,06	9,09	12,96
Amoxicillin	0	0	0	0	0	0	2,30	2,15	2,38	6,45	5,05	10,19
Metronidazole tab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,42	0	0
Metronidazole inf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,23	0	0

SMF Obgyn 2025



Gambar 2. Grafik Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Obgyn

Analisis :

Penggunaan antibiotik pada tahun 2025 oleh SMF Obgyn terdiri dari 6 antibiotik diantaranya Cefazoline, Cefadroxile, Ceftriaxone, Amoxicillin, Metronidazole tab, Metronidazole inf. Antibiotik yang paling banyak digunakan oleh SMF bedah adalah antibiotik Cefadroxile. Nilai tertinggi terdapat di bulan Januari sebesar 28,85 DDD/100 hari rawat inap. Hasil tersebut dapat dikaitkan dengan pemberian Cefadroxile sebagai terapi post SC sesuai dengan *Clinical Pathway* di RS Prima Husada Malang.

Rencana Tindak Lanjut :

Penggunaan antibiotik pada SMF Obgyn tahun 2025 sudah sesuai dengan *Clinical Pathway* di RS Prima Husada Malang, maka perlu dipertahankan.

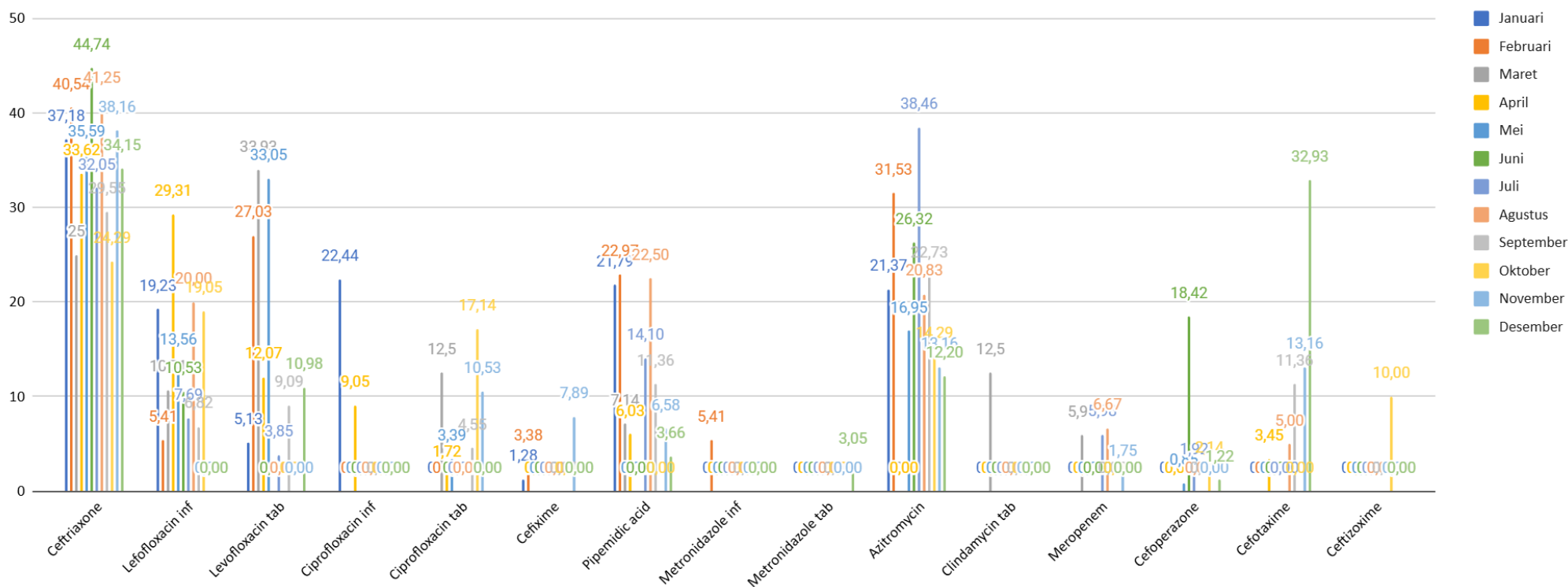
3.5.3. SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung

Table 5. Penggunaan antibiotik secara kuantitatif pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung

Nama Obat	Bulan (DDD/100)											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Ceftriaxone	37,18	40,54	25	33,62	35,59	44,74	32,05	41,25	29,55	24,29	38,16	34,15
Lefofloxacin inf	19,23	5,41	10,71	29,31	13,56	10,53	7,69	20,00	6,82	19,05	0	0
Levofloxacin tab	5,13	27,03	33,93	12,07	33,05	0	3,85	0	9,09	0	0	10,98
Ciprofloxacin inf	22,44	0	0	9,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciprofloxacin tab	0	0	12,5	1,72	3,39	0	0	0	4,55	17,14	10,53	0
Cefixime	1,28	3,38	0	0	0	0	0	0	0	0	7,89	0
Pipemidic acid	21,79	22,97	7,14	6,03	0	0	14,10	22,50	11,36	0	6,58	3,66

Metronidazole inf	0	5,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Metronidazole tab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,05
Azitromycin	21,37	31,53	0	0	16,95	26,32	38,46	20,83	22,73	14,29	13,16	12,20
Clindamycin tab	0	0	12,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meropenem	0	0	5,95	0	0	0	5,98	6,67	0,00	0	1,75	0
Cefoperazone	0	0	0	0	0,85	18,42	1,92	0	0,00	2,14	0	1,22
Cefotaxime	0	0	0	3,45	0	0	0	5,00	11,36	0	13,16	32,93
Ceftizoxime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,00	0	0

SMF IPD, Paru, Syaraf, Jantung



Gambar 3. Grafik Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung

Analisis :

Penggunaan antibiotik pada tahun 2025 oleh SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung terdiri dari 15 antibiotik diantaranya Ceftriaxone, Levofloxacin inf, Levofloxacin tab, Ciprofloxacin inf, Ciprofloxacin tab, Cefixime, Asam Pipemidat, Metronidazole inf, Metronidazole tab, Azitromycin, Clindamycin tab, Meropenem, Cefoperazone, Cefotaxime dan Ceftizoxime. Antibiotik yang paling banyak digunakan oleh SMF bedah adalah antibiotik Ceftriaxone. Nilai tertinggi terdapat di bulan Juni sebesar 44,74 DDD/100 hari rawat inap. Hasil tersebut dapat dikaitkan dengan pemberian Ceftriaxone sebagai terapi empiris pada kebanyakan diagnosis infeksi di RS Prima Husada malang.

Rencana Tindak Lanjut :

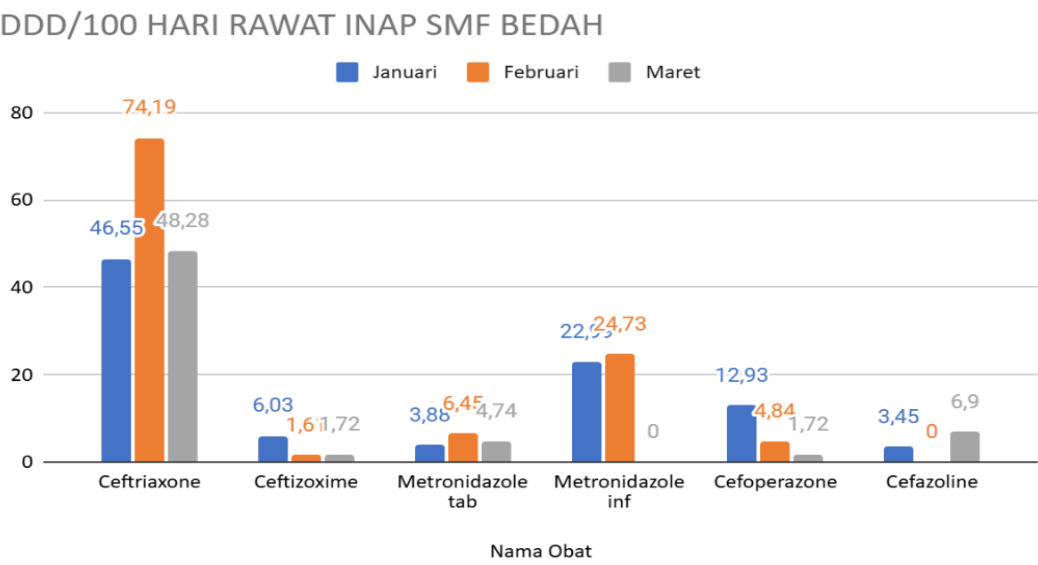
Pemberian antibiotik Ceftriaxone pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung tahun 2025 masih termasuk cukup tinggi sehingga perlu dukungan manajemen melalui komite medis untuk melakukan supervisi dan sosialisasi terkait penggunaan antibiotik yang bijak dan rasional.

3.6. Kuantitas Penggunaan Antibiotik DDD TW I

3.6.1. SMF Bedah

Tabel 6. Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Bedah TW I Tahun 2025

No	Nama Obat	Bulan (DDD/100 hari rawat inap)		
		Januari	Februari	Maret
1	Ceftriaxone	46,55	74,19	48,28
2	Ceftizoxime	6,03	1,61	1,72
3	Metronidazole tab	3,88	6,45	4,74
4	Metronidazole inf	22,99	24,73	0
5	Cefoperazone	12,93	4,84	1,72
6	Cefazoline	3,45	0	6,90



Gambar 4. Grafik Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Bedah TW I

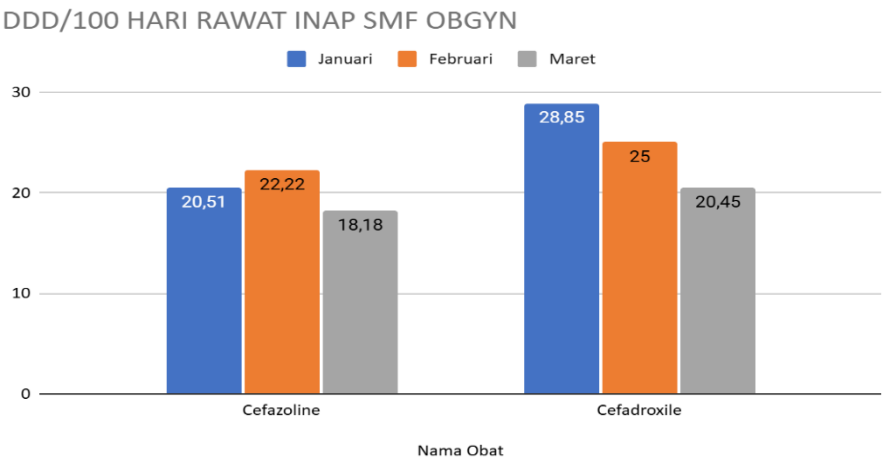
Analisis :

Penggunaan antibiotik pada triwulan I tahun 2025 oleh SMF Bedah terdiri dari Ceftriaxone, Ceftizoxime, Metronidazole po, Metronidazole inf, Cefoperazone, dan Cefazoline. Antibiotik yang paling banyak digunakan oleh SMF bedah adalah antibiotik Ceftriaxone. Nilai tertinggi terdapat di bulan Februari sebesar 74,19 DDD/100 hari rawat inap. Hasil tersebut dapat dikaitkan dengan pemberian Ceftriaxone sebagai terapi empiris pada kebanyakan diagnosis infeksi di RS Prima Husada malang.

3.6.2. SMF Obgyn

Tabel 7. Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Obgyn TW I Tahun 2025

No	Nama Obat	Bulan (DDD/100 hari rawat inap)		
		Januari	Februari	Maret
1	Cefazoline	20,51	22,22	18,18
2	Cefadroxile	28,85	25	20,45



Gambar 5. Grafik Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Obgyn TW I

Analisis :

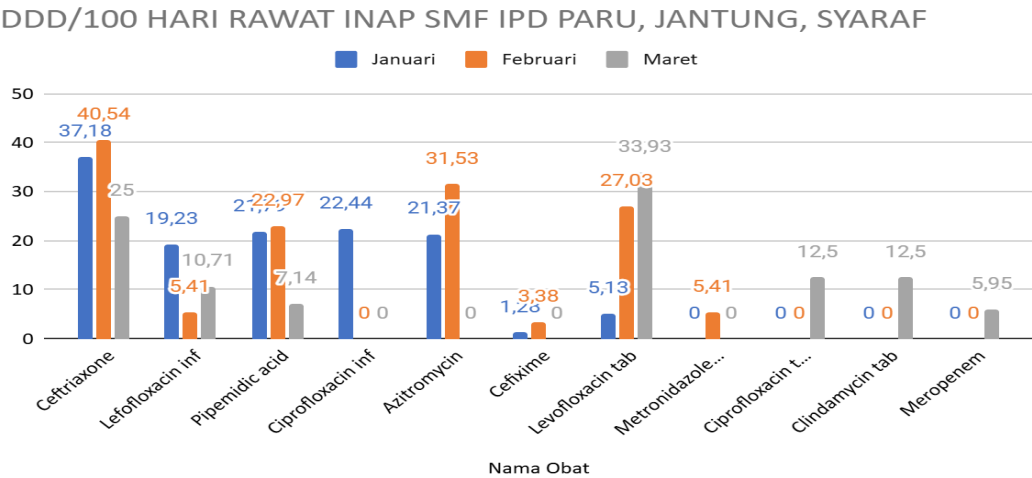
Penggunaan antibiotik pada SMF Obgyn terdiri dari Cefazolin dan Cefadroxile. Antibiotik yang paling banyak di gunakan pada SMF Obgyn adalah antibiotik Cefadroxile. Nilai DDD/100 tertinggi terdapat pada bulan Januari sebesar 28,85 DDD/100 hari rawat inap.

3.6.3. SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung

Tabel 8. Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung TW I 2025

No	Nama Obat	Bulan (DDD/100 hari rawat inap)		
		Januari	Februari	Maret
1	Ceftriaxone	37,18	40,54	25,00
2	Levofloxacin inf	19,23	5,41	10,71

3	Pipemidic acid	21,79	22,97	7,14
4	Ciprofloxacin inf	22,44	0	0
5	Azithromycin	21,37	31,53	0
6	Cefixime	1,28	3,38	0
7	Levofloxacin tab	5,13	27,03	33,93
8	Metronidazole inf	0	5,41	0
9	Ciprofloxacin tab	0	0	12,50
10	Clindamycin tab	0	0	12,50
11	Meropenem	0	0	5,95



Gambar 6. Grafik Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung TW I

Analisis :

Penggunaan antibiotik oleh SMF IPD, Jantung, Paru dan Syaraf pada triwulan I terdiri dari 11 macam antibiotik. Antibiotik yang paling banyak di gunakan pada SMF IPD, Jantung, Paru dan Syaraf adalah antibiotik Ceftriaxone. Nilai tertinggi penggunaan Ceftriaxoen terdapat dibulan februari dengan nilai 40,54 DDD/100 hari rawat inap. Pada triwulan I terdapat penggunaan antibiotik kategori reserve yaitu Meropenem. Nilai DDD/100 dari antibiotik meropenem sebesar 5,95.

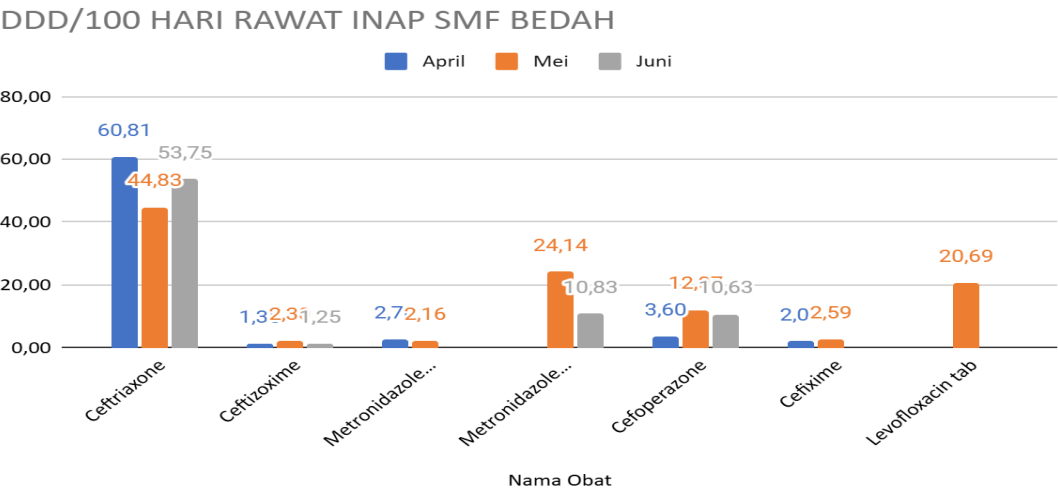
3.7. Kuantitas Penggunaan Antibiotik DDD TW II

3.7.1. SMF Bedah

Tabel 9. Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Bedah TW II 2025

No	Nama Obat	Bulan (DDD/100 hari rawat inap)		
		April	Mei	Juni
1	Ceftriaxone	60,81	44,83	53,75

2	Ceftizoxime	1,35	2,30	1,25
3	Metronidazole tab	2,70	2,16	0
4	Metronidazole inf	0	24,14	10,83
5	Cefoperazone	3,60	12,07	10,63
6	Cefixime	2,03	2,59	0
7	Levofloxacin tab	0	20,69	0



Gambar 7. Grafik Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Bedah TW II

Analisis :

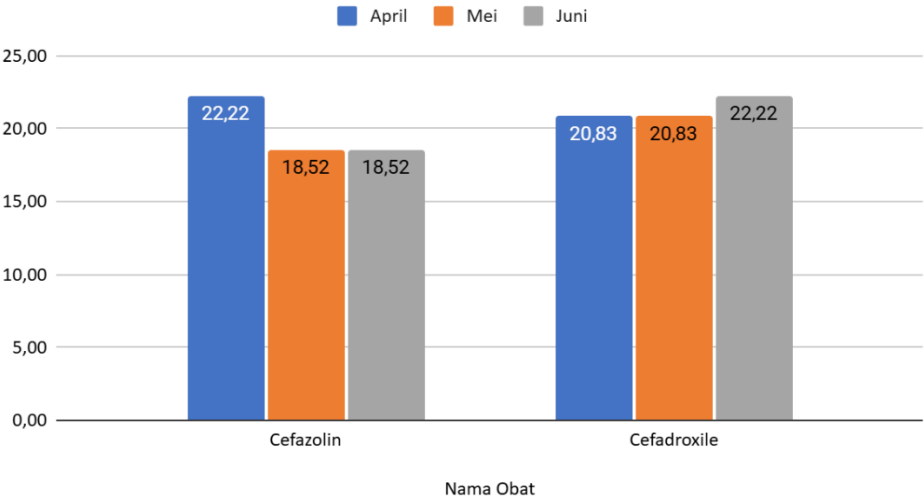
Penggunaan antibiotik pada triwulan II tahun 2025 oleh SMF Bedah terdiri dari Ceftriaxone, Ceftizoxime, Metronidazole po, Metronidazole inf, Cefoperazone, Cefixime dan Levofloxacin po. Antibiotik yang paling banyak digunakan oleh SMF bedah adalah antibiotik Ceftriaxone. Nilai tertinggi terdapat di bulan April sebesar 60,81 DDD/100 hari rawat inap. Hasil tersebut dapat dikaitkan dengan pemberian Ceftriaxone sebagai terapi empiris pada kebanyakan diagnosis infeksi di RS Prima Husada malang.

3.7.2. SMF Obgyn

Tabel 10. Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Obgyn TW II 2025

No	Nama Obat	Bulan (DDD/100 hari rawat inap)		
		April	Mei	Juni
1	Cefazoline	22,22	18,52	18,52
2	Cefadroxile	20,83	20,83	22,22

DDD/100 HARI RAWAT INAP SMF OBGYN



Gambar 8. Grafik Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Obgyn TW II

Analisis :

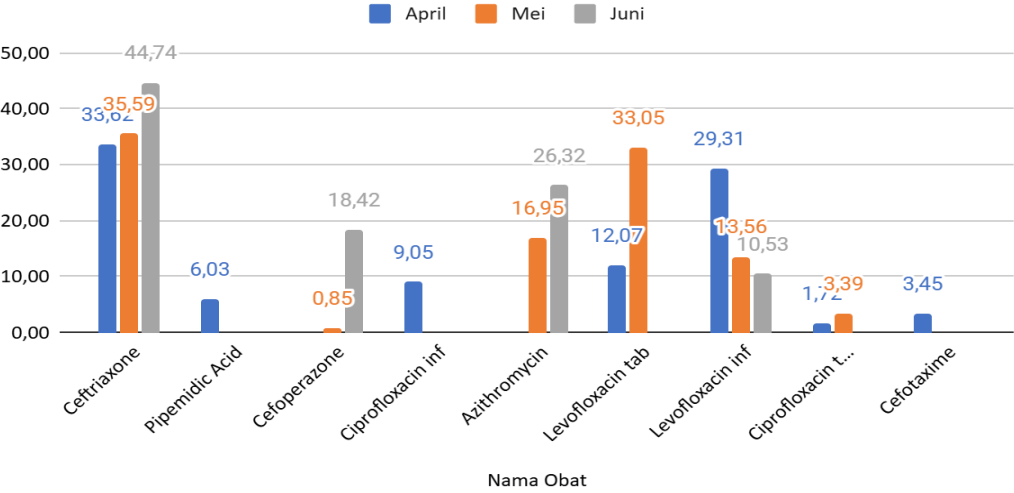
Penggunaan antibiotik pada SMF Obgyn terdiri dari Cefazolin dan Cefadroxile. Antibiotik yang paling banyak di gunakan pada SMF Obgyn adalah antibiotik Cefadroxile dan Cefazoline. Nilai DDD/100 Cefazoline tertinggi terdapat pada bulan April sebesar 22,22 DDD/100 hari rawat inap. Sedangkan Nilai DDD/100 Cefadroxile tertinggi terdapat pada bulan Juni sebesar 22,22 DDD/100 hari rawat inap

3.7.3. SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung

Tabel 11. Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Obgyn TW II 2025

No	Nama Obat	Bulan (DDD/100 hari rawat inap)		
		April	Mei	Juni
1	Ceftriaxone	33,62	35,59	44,74
2	Pipemidic Acid	6,03	0	0
3	Cefoperazone	0	0,85	18,42
4	Ciprofloxacin inf	9,05	0	0
5	Azithromycin	0	16,95	26,32
6	Levofloxacin tab	12,07	33,05	0
7	Levofloxacin inf	29,31	13,56	10,53
8	Ciprofloxacin tab	1,72	3,39	0
9	Cefotaxime	3,45	0	0

DDD/100 HARI RAWAT INAP SMF IPD PARU, JANTUNG, SYARAF



Gambar 9. Grafik Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung TW II

Analisis :

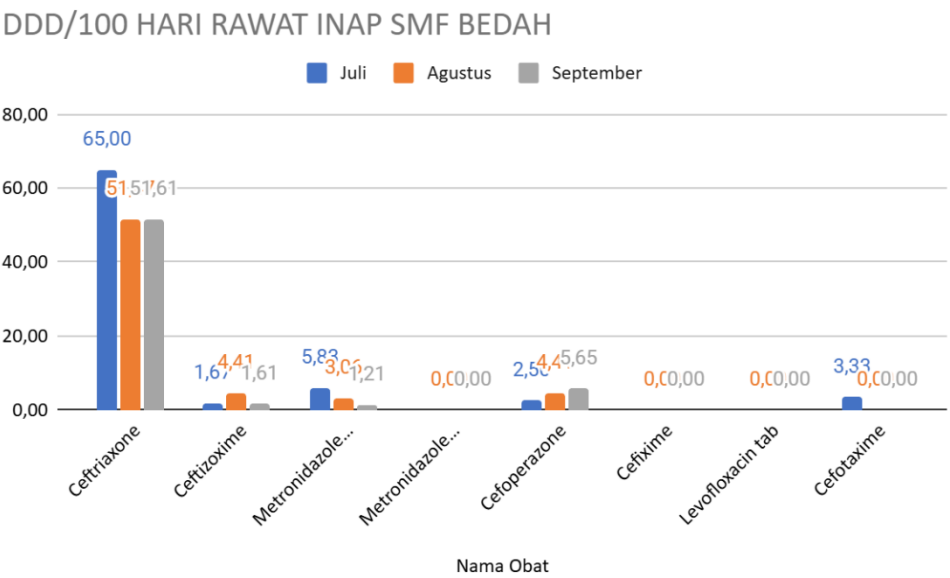
Penggunaan antibiotik oleh SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung pada triwulan II terdiri dari 9 macam antibiotik. Antibiotik yang paling banyak di gunakan pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung adalah antibiotik Ceftriaxone. Nilai tertinggi penggunaan Ceftriaxoen terdapat dibulan Juni dengan nilai 44,74 DDD/100 hari rawat inap.

3.8. Kuantitas Penggunaan Antibiotik DDD TW III

3.8.1. SMF Bedah

Tabel 12. Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Bedah TW III 2025

No	Nama Obat	Bulan (DDD/100 hari rawat inap)		
		Juli	Agustus	September
1	Ceftriaxone	65,00	51,47	51,61
2	Ceftizoxime	1,67	4,41	1,61
3	Metronidazole tab	5,83	3,06	1,21
4	Metronidazole inf	0	0,00	0,00
5	Cefoperazone	2,50	4,41	5,65
6	Cefixime	0	0,00	0,00
7	Levofloxacin tab	0	0,00	0,00
8	Cefotaxime	3,33	0,00	0,00



Gambar 10. Grafik Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Bedah TW III

Analisis :

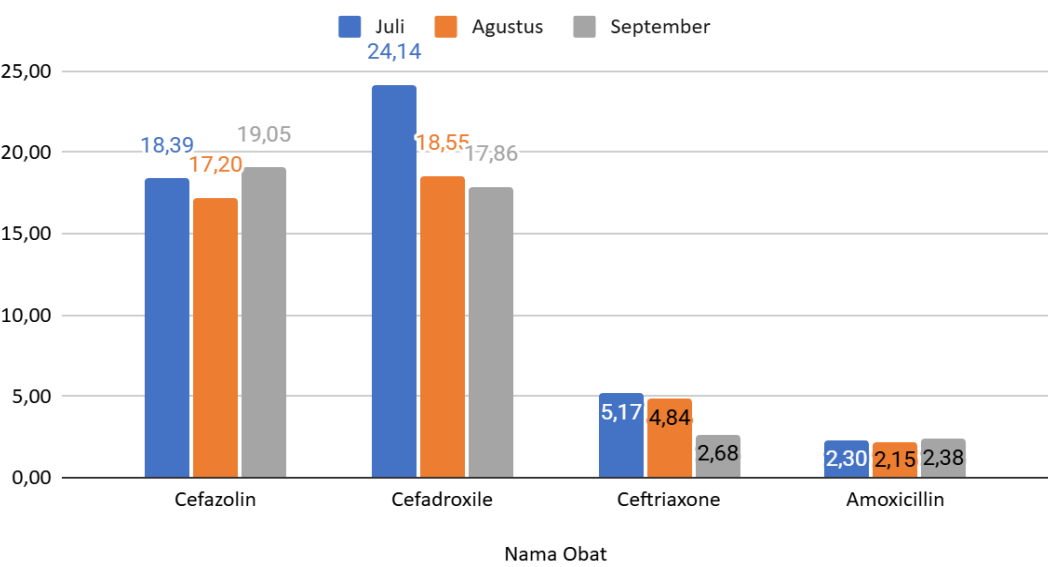
Penggunaan antibiotik pada triwulan III tahun 2025 oleh SMF Bedah terdiri dari Ceftriaxone, Ceftizoxime, Metronidazole po, Metronidazole inf, Cefoperazone, Cefixime, Levofloxacin po, dan Cefotaxime. Antibiotik yang paling banyak digunakan oleh SMF bedah adalah antibiotik Ceftriaxone. Nilai tertinggi terdapat di bulan Juli sebesar 65,00 DDD/100 hari rawat inap. Hasil tersebut dapat dikaitkan dengan pemberian Ceftriaxone sebagai terapi empiris pada kebanyakan diagnosis infeksi di RS Prima Husada Malang.

3.8.2. SMF Obgyn

Tabel 13. Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Obgyn TW III 2025

No	Nama Obat	Bulan (DDD/100 hari rawat inap)		
		Juli	Agustus	September
1	Cefazoline	18,39	17,20	19,05
2	Cefadroxile	24,14	18,55	17,86
3	Ceftriaxone	5,17	4,84	2,68
4	Amoxicillin	2,30	2,15	2,38

DDD/100 HARI RAWAT INAP SMF OBGYN



Gambar 11. Grafik Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Obgyn TW III

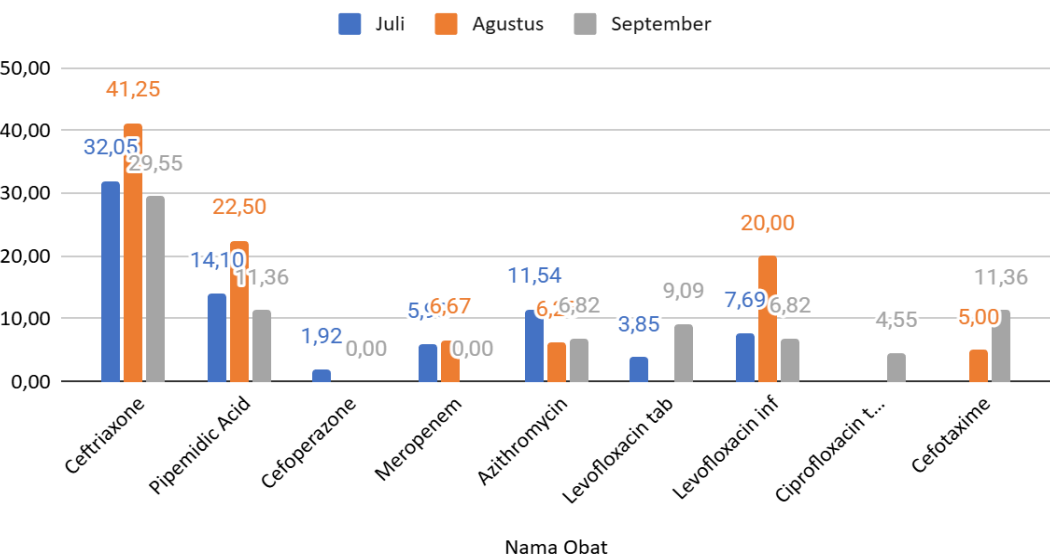
Analisis :
Penggunaan antibiotik pada SMF Obgyn terdiri dari Cefazolin, Cefadroxile, Ceftriaxone, dan Amoxicillin. Antibiotik yang paling banyak di gunakan pada SMF Obgyn adalah antibiotik Cefadroxile. Nilai DDD/100 Cefadroxile tertinggi terdapat pada bulan Juli sebesar 24,14 DDD/100 hari rawat inap.

3.8.3. SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung

Tabel 14. Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung TW III 2025

No	Nama Obat	Bulan (DDD/100 hari rawat inap)		
		Juli	Agustus	September
1	Ceftriaxone	32,05	41,25	29,55
2	Pipemidic Acid	14,10	22,50	11,36
3	Cefoperazone	1,92	0	0,00
4	Meropenem	5,98	6,67	0,00
5	Azithromycin	11,54	6,25	6,82
6	Levofloxacin tab	3,85	0	9,09
7	Levofloxacin inf	7,69	20,00	6,82
8	Ciprofloxacin tab	0	0	4,55
9	Cefotaxime	0	5,00	11,36
10	Clindamycin tab	0	0	12,50

DDD/100 HARI RAWAT INAP SMF IPD PARU, JANTUNG, SYARAF



Gambar 12. Grafik Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF IPD, Paru, Syaraf, Jantung TW III

Analisis :

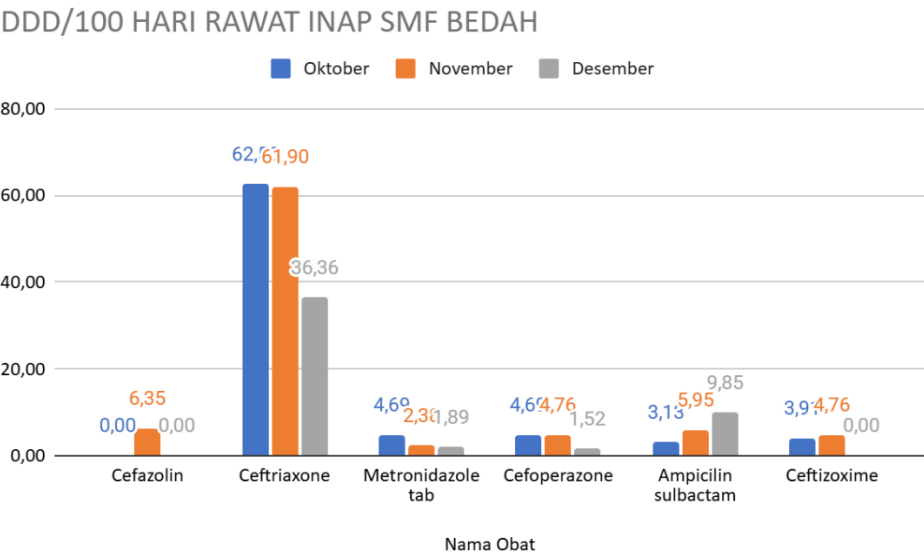
Penggunaan antibiotik oleh SMF IPD, Jantung, Paru dan Syaraf pada triwulan III terdiri dari 9 macam antibiotik. Antibiotik yang paling banyak di gunakan pada SMF SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung adalah antibiotik Ceftriaxone. Nilai tertinggi penggunaan Ceftriaxoen terdapat dibulan Mei dengan nilai 41,25 DDD/100 hari rawat inap.

3.9. Kuantitas Penggunaan Antibiotik DDD TW IV

3.9.1. SMF Bedah

Tabel 15. Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Bedah TW IV 2025

No	Nama Obat	Bulan (DDD/100 hari rawat inap)		
		Oktober	November	Desember
1	Cefazoline	0,00	6,35	0,00
2	Ceftriaxone	62,50	61,90	36,36
3	Metronidazole tab	4,69	2,38	1,89
4	Cefoperazone	4,69	4,76	1,52
5	Ampicilin Sulbactam	3,13	5,95	9,85
6	Ceftizoxime	3,91	4,76	0,00
7	Levofloxacin tab	0	0,00	0,00
8	Cefotaxime	3,33	0,00	0,00



Gambar 13. Grafik Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Bedah TW IV

Analisis :

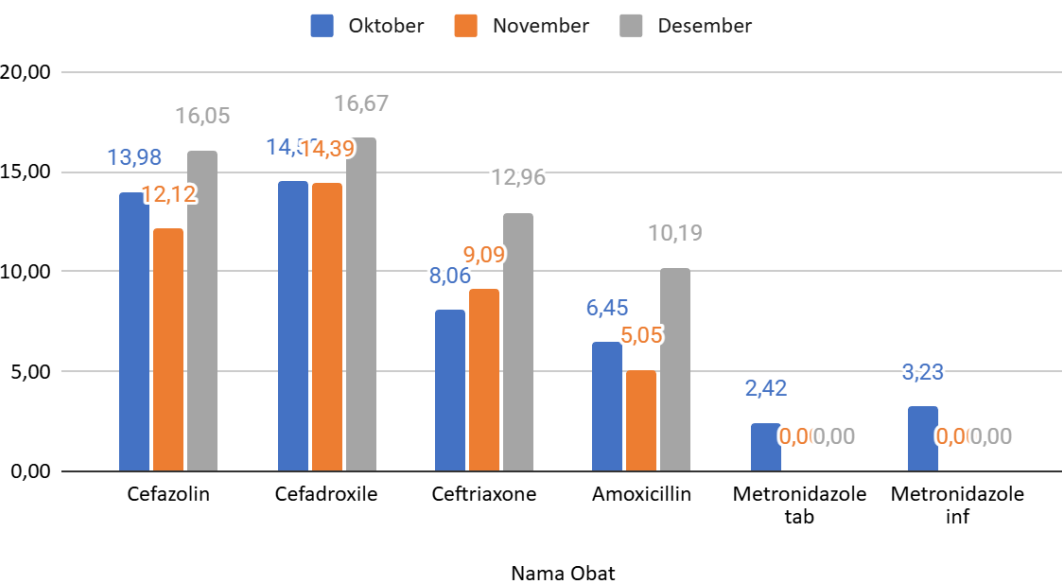
Penggunaan antibiotik pada triwulan IV tahun 2025 oleh SMF Bedah terdiri dari Ceftriaxone, Ceftizoxime, Metronidazole tab, Ampicilin sulbactam, Cefazolin, Cefoperazone. Antibiotik yang paling banyak digunakan oleh SMF bedah adalah antibiotik Ceftriaxone. Nilai tertinggi terdapat di bulan Oktober sebesar 62,50 DDD/100 hari rawat inap. Hasil tersebut dapat dikaitkan dengan pemberian Ceftriaxone sebagai terapi empiris pada kebanyakan diagnosis infeksi di RS Prima Husada Malang.

3.9.2. SMF Obgyn

Tabel 16. Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Obgyn TW IV 2025

No	Nama Obat	Bulan (DDD/100 hari rawat inap)		
		Juli	Agustus	September
1	Cefazolin	13,98	12,12	16,05
2	Cefadroxile	14,52	14,39	16,67
3	Ceftriaxone	8,06	9,09	12,96
4	Amoxicillin	6,45	5,05	10,19
5	Metronidazole tab	2,42	0,00	0,00
6	Metronidazole inf	3,23	0,00	0,00

DDD/100 HARI RAWAT INAP SMF OBGYN



Gambar 14. Grafik Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF Obgyn TW IV

Analisis :

Penggunaan antibiotik pada SMF Obgyn terdiri dari Cefazolin, Cefadroxile, Ceftriaxone, Amoxicillin, Metronidazole tab, dan Metronidazole infus. Antibiotik yang paling banyak di gunakan pada SMF Obgyn adalah antibiotik Cefadroxile. Nilai DDD/100 Cefadroxile tertinggi terdapat pada bulan Desember sebesar 16,67 DDD/100 hari rawat inap.

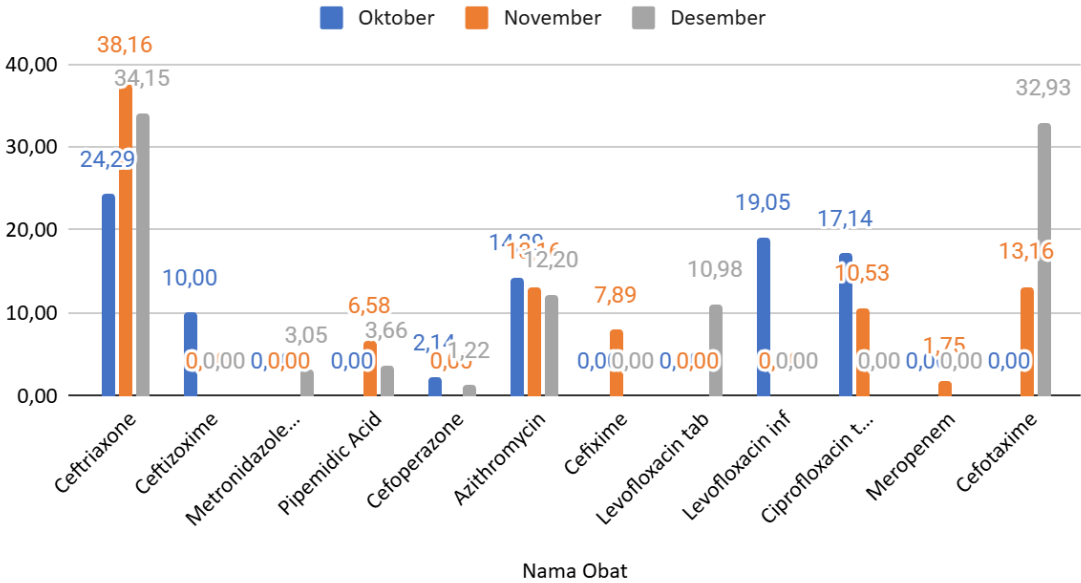
3.9.3. SMF IPD, Paru, Syaraf, Jantung

Tabel 17. Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung TW IV 2025

No	Nama Obat	Bulan (DDD/100 hari rawat inap)		
		Oktober	November	Desember
1	Ceftriaxone	24,29	38,16	34,15
2	Ceftizoxime	10,00	0,00	0,00
3	Metronidazole tab	0,00	0,00	3,05
4	Pipemidic Acid	0,00	6,58	3,66
5	Cefoperazone	2,14	0,00	1,22
6	Azithromycin	14,29	13,16	12,20
7	Cefixime	0,00	7,89	0,00
8	Levofloxacin tab	0,00	0,00	10,98
9	Levofloxacin inf	19,05	0,00	0,00
10	Ciprofloxacin tab	17,14	10,53	0,00
11	Meropenem	0,00	1,75	0,00

12	Cefotaxime	0,00	13,16	32,93
----	------------	------	-------	-------

DDD/100 HARI RAWAT INAP SMF IPD PARU, JANTUNG, SYARAF



Gambar 15. Grafik Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada SMF IPD, Paru, Syaraf, Jantung TW IV

Analisis :

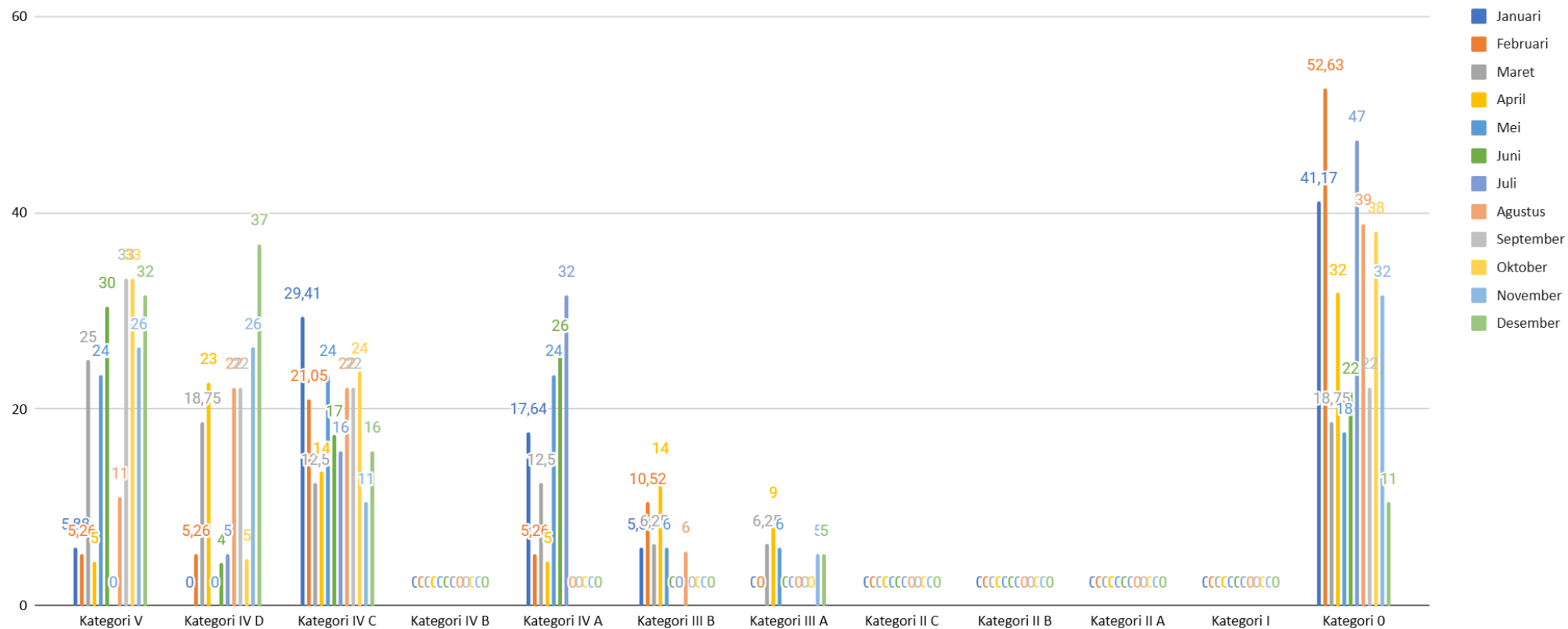
Penggunaan antibiotik oleh SMF IPD, Jantung, Paru dan Syaraf pada triwulan IV terdiri dari 12 macam antibiotik. Antibiotik yang paling banyak di gunakan pada SMF IPD, Jantung, Paru dan Syaraf adalah antibiotik Ceftriaxone. Nilai tertinggi penggunaan Ceftriaxoen terdapat dibulan Mei dengan nilai 38,16 DDD/100 hari rawat inap.

3.10. Kualitas Penggunaan Antibiotik (Gyssens)

3.10.1. SMF Bedah

Tabel 18. Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuanlitatif pada SMF Bedah

Kategori Gyssens	Jumlah (%)											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Kategori V	5,88	5,26	25	5	24	30	0	11	33	33	26	32
Kategori IV D	0	5,26	18,75	23	0	4	5	22	22	5	26	37
Kategori IV C	29,41	21,05	12,5	14	24	17	16	22	22	24	11	16
Kategori IV B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kategori IV A	17,64	5,26	12,5	5	24	26	32	0	0	0	0	0
Kategori III B	5,88	10,52	6,25	14	6	0	0	6	0	0	0	0
Kategori III A	0	0	6,25	9	6	0	0	0	0	0	5	5
Kategori II C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kategori II B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kategori II A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kategori I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kategori 0	41,17	52,63	18,75	32	18	22	47	39	22	38	32	11



Gambar 16. Grafik Audit Penggunaan Antibiotik secara Kualitatif pada SMF Bedah

Analisis :

1. Pada SMF Bedah tahun 2025 terdapat kategori 0 yaitu penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase kategori 0 tertinggi dan memenuhi

standar pada SMF Bedah terdapat pada bulan Februari sebesar 52,63 %.

2. Kategori IV D paling tinggi terdapat pada SMF Bedah tahun 2025 sebesar 37 % dibulan Desember yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya.
3. Kategori V paling tinggi terdapat pada SMF Bedah tahun 2025 sebesar 33 % dibulan September dan Oktober yang menunjukkan adanya pemberian antibiotik namun tidak ada indikasi.

Rencana Tindak Lanjut :

- a. Untuk SMF bedah pada bulan Februari, persentase Gyssens kategori 0 sudah memenuhi standar, maka perlu dipertahankan dan ditingkatkan
- b. Untuk persentase Gyssens kategori V yaitu pemberian antibiotik tanpa indikasi masih termasuk cukup tinggi sehingga perlu dukungan manajemen melalui komite medis untuk melakukan supervisi dan sosialisasi terkait penggunaan antibiotik yang bijak dan rasional.

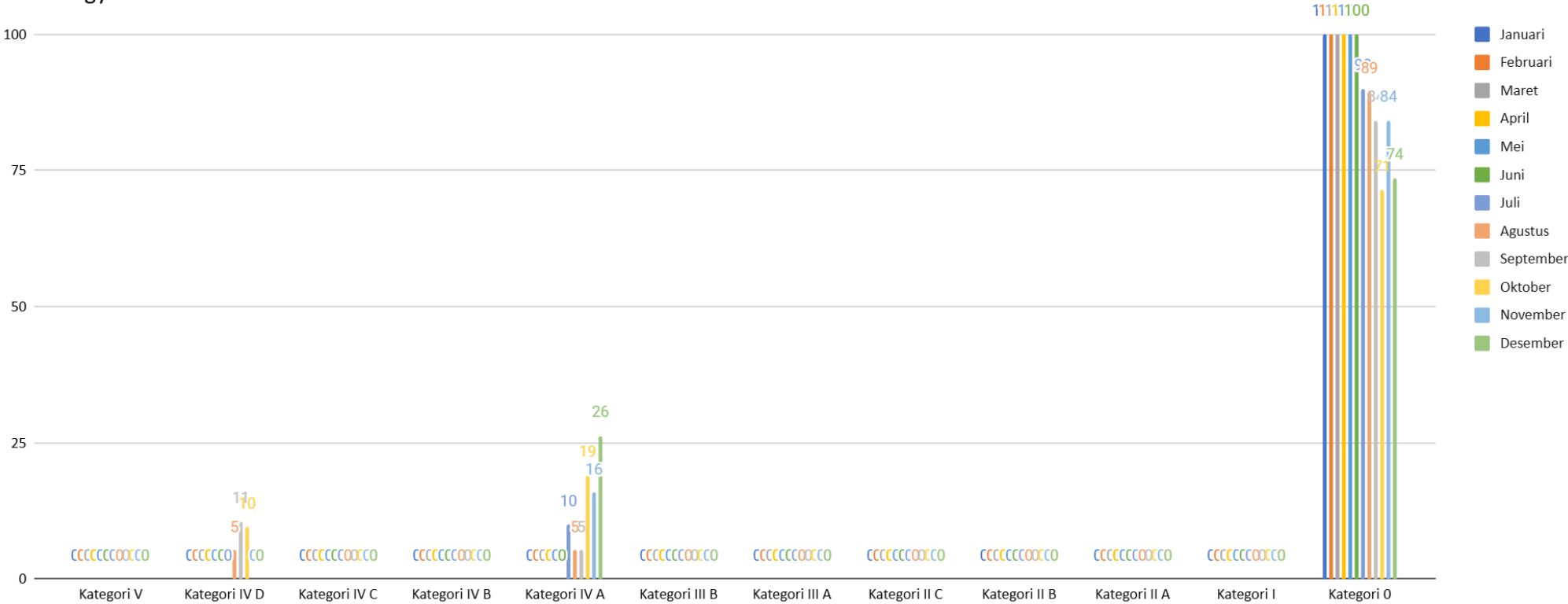
3.10.2. SMF Obgyn

Tabel 19. Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuanlitatif pada SMF Obgyn

Kategori Gyssens	Jumlah (%)											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Kategori V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kategori IV D	0	0	0	0	0	0	0	5	11	10	0	0
Kategori IV C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kategori IV B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kategori IV A	0	0	0	0	0	0	10	5	5	19	16	26
Kategori III B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kategori III A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kategori II C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kategori II B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kategori II A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kategori I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kategori 0	100	100	100	100	100	100	90	90	84	71	84	74

SMF Obgyn 2025



Gambar 17. Grafik Audit Penggunaan Antibiotik secara Kualitattif pada SMF Obgyn

Analisis :

1. Pada SMF Obgyn terdapat kategori 0 yang menunjukkan penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase tertingginya 100% pada triwulan I dan triwulan II. Hasil tersebut memenuhi standart yaitu perolehan persentase kategori 0 $\geq$ 50%.
2. Kategori IV A, ada pada bulan Desember dengan prosentase terbesar yaitu 26% yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih efektif
3. Kategori IV D paling tinggi terdapat pada SMF Obgyn sebesar 11% dibulan September yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya.

Rencana Tindak Lanjut :

Untuk SMF Obgyn, persentase Gyssens kategori 0 (Pemberian antibiotik bijak dan rasional) seluruhnya telah mencapai standar. Masih terdapat beberapa kategori lain seperti kategori IV A yaitu pemilihan antibiotik yang tidak efektif, dan IV D yaitu penggunaan antibiotik yang tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya. Namun, persentasenya kecil sehingga perlu dipertahankan dan diperbaiki.

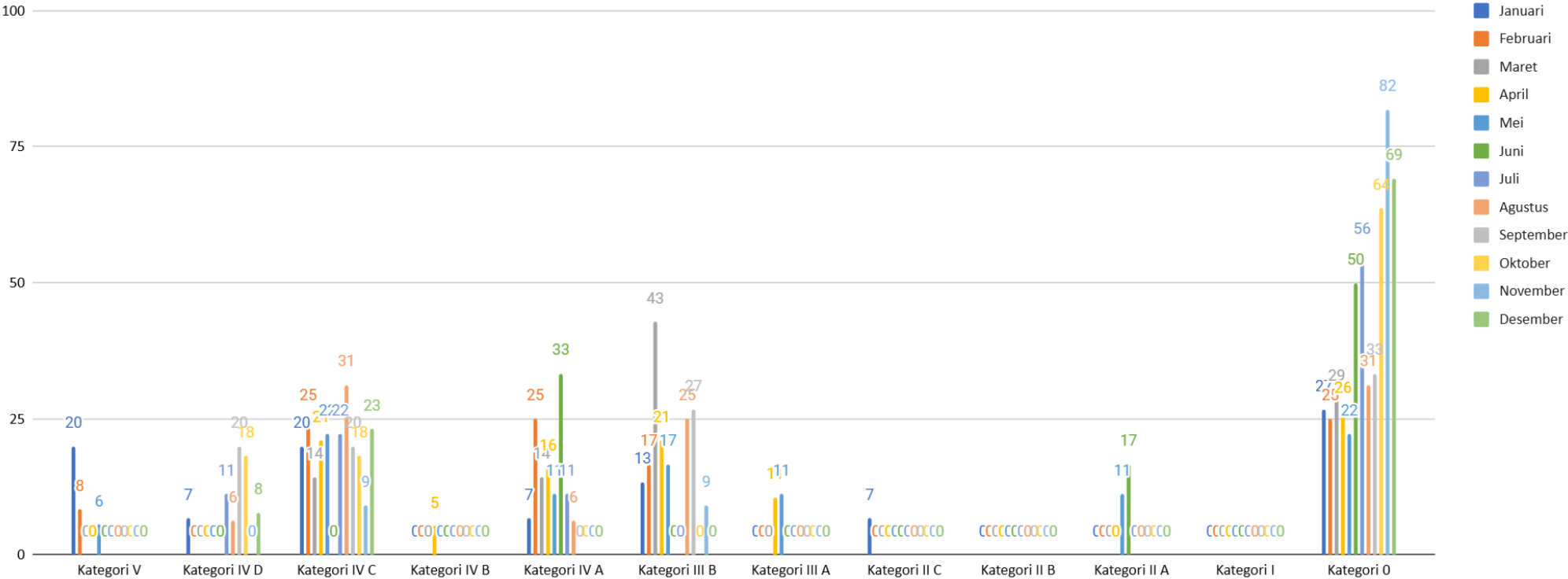
3.10.3. SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung

Tabel 20. Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuanlitatif pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung

Kategori Gyssens	Jumlah (%)											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Kategori V	20	8	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Kategori IV D	7	0	0	0	0	0	11	6	20	18	0	8
Kategori IV C	20	25	14	21	22	0	22	31	20	18	9	23
Kategori IV B	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Kategori IV A	7	25	14	16	11	33	11	6	0	0	0	0
Kategori III B	13	17	43	21	17	0	0	25	27	0	9	0

Kategori III A	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0
Kategori II C	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kategori II B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kategori II A	0	0	0	0	11	17	0	0	0	0	0	0
Kategori I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kategori 0	27	25	29	26	22	50	56	31	33	64	82	69

SMF IPD, Paru, Syaraf, Jantung 2025



Gambar 18. Grafik Audit Penggunaan Antibiotik secara Kualitattif pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung

Analisis :

1. Pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung tahun 2025 terdapat kategori 0 yaitu penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase kategori 0 tertinggi dan memenuhi standar pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung terdapat pada bulan November sebesar 80,00 %.

2. Kategori III B tertinggi pada SMF IPD, Jantung, Paru, Syaraf dengan prosentase sebesar 43% dibulan Maret yang menunjukkan durasi pemberian antibiotik terlalu pendek.
3. Kategori IV A tertinggi pada SMF IPD, Jantung, Paru, Syaraf. Prosentase tertinggi sebesar 33% dibulan Juli yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih efektif.

Rencana Tindak Lanjut :

Untuk SMF IPD, Jantung, Paru, Syaraf, persentase Gyssens kategori 0 (Pemberian antibiotik bijak dan rasional) pada bulan Juni, Juli, Oktober, November dan Desember telah mencapai standar. Namun tetap ada pemberian antibiotik yang masih kurang tepat. Sehingga tetap perlu adanya perbaikan untuk berikutnya.

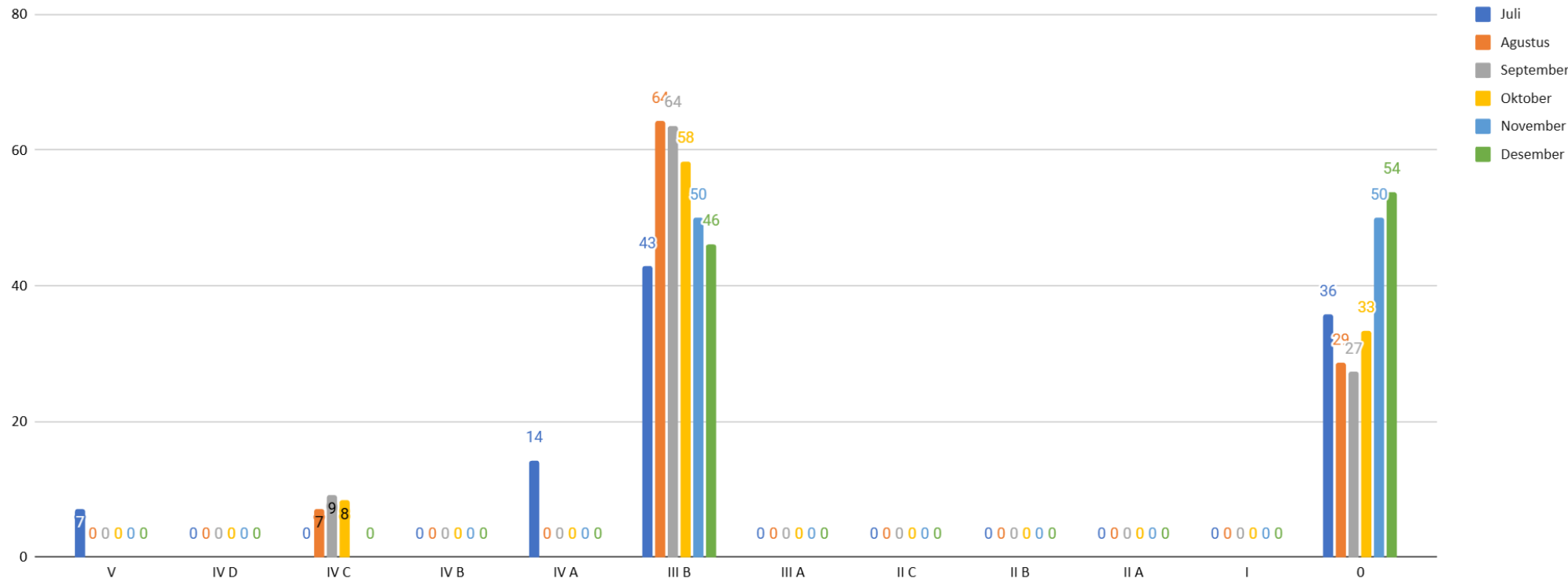
3.10.4. SMF Anak

Tabel 21. Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuanlitatif pada SMF Anak

Kategori Gyssens	Jumlah (%)											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Kategori V	-	-	-	-	-	-	7	0	0	0	0	0
Kategori IV D	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Kategori IV C	-	-	-	-	-	-	0	7	9	8	0	0
Kategori IV B	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Kategori IV A	-	-	-	-	-	-	14	0	0	0	0	0
Kategori III B	-	-	-	-	-	-	43	64	64	58	50	46
Kategori III A	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Kategori II C	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Kategori II B	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

Kategori II A	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Kategori I	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Kategori 0	-	-	-	-	-	-	36	29	27	33	50	54

SMF Anak 2025



Gambar 19. Grafik Audit Penggunaan Antibiotik secara Kualitatif pada SMF Anak

Analisis :

1. Pada tahun 2025, terdapat kategori 0 yaitu penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase kategori 0 tertinggi terdapat pada bulan Desember sebesar 54%.
2. Kategori III B, dengan prosentase sebesar 64% terbesar dibulan Agustus dan September yang menunjukkan durasi pemberian antibiotik terlalu pendek.
3. Kategori IV C terdapat prosentase 9% dibulan September yang menunjukkan pilihan antibiotik kurang tepat karena terdapat antibiotik lain yang lebih murah

Rencana Tindak Lanjut :

Untuk SMF Anak, terdapat persentase Gyssens kategori 0 (Pemberian antibiotik bijak dan rasional) dengan prosentase tertinggi 54%. Namun terdapat juga pemberian antibiotik yang masih kurang tepat, ditunjukkan dengan adanya kategori lain. Sehingga perlu adanya perbaikan untuk berikutnya supervisi dan sosialisasi terkait penggunaan antibiotik yang bijak dan rasional.

3.11. Kualitas Penggunaan Antibiotik (Gyssens) TW I

3.11.1. SMF Bedah

Tabel 22. Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuanlitatif pada SMF Bedah

No	Kriteria Gyssens	Standar	Bulan		
			Januari (%)	Februari (%)	Maret (%)
1	Kategori 0	≥ 50	41,17	52,63	18,75
2	Kategori 1	0	0	0	0
3	Kategori 2A	0	0	0	0
4	Kategori 2B	0	0	0	0
5	Kategori 2C	0	0	0	0
6	Kategori 3A	0	0	0	6,25
7	Kategori 3B	0	5,88	10,52	6,25
8	Kategori 4A	0	17,66	5,26	12,5
9	Kategori 4B	0	0	0	0
10	Kategori 4C	0	29,41	21,07	12,5
11	Kategori 4D	0	0	5,26	18,75
12	Kategori 5	0	5,88	5,26	25

Analisis :

- 4. Pada triwulan I terdapat kategori 0 yaitu penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase kategori 0 tertinggi pada SMF Bedah terdapat pada bulan Februari sebesar 52,63 %.
- 5. Kategori III A terdapat pada SMF Bedah dengan prosentase sebesar 6,25 % yang menunjukkan durasi pemberian antibiotik terlalu lama.
- 6. Kategori III B terdapat pada SMF Bedah. Prosentase tertinggi terdapat pada bulan Februari sebesar 10,52 % yang menunjukkan durasi pemberian antibiotik terlalu singkat.
- 7. Kategori IV A tertinggi pada SMF Bedah dengan prosentase sebesar 17,64 % dibulan Januari yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih efektif.
- 8. Kategori IV C paling tinggi terdapat pada SMF Bedah sebesar 29,41 % dibulan Januari yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena terdapat antibiotik lain yang lebih murah.
- 9. Kategori IV D paling tinggi terdapat pada SMF Bedah sebesar 18,75 % dibulan Maret yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya.
- 10. Kategori V terdapat pada SMF Bedah sebesar 25 % dibulan Maret yang menunjukkan adanya pemberian antibiotik namun tidak ada indikasi.

Rencana tindak lanjut

- a. Untuk SMF bedah pada bulan Februari, persentase Gyssens kategori 0 sudah

memenuhi standar, maka perlu dipertahankan dan ditingkatkan

- b. Untuk persentase Gyssens kategori V yaitu pemberian antibiotik tanpa indikasi masih termasuk cukup tinggi sehingga perlu dukungan manajemen melalui komite medis untuk melakukan supervisi dan sosialisasi terkait penggunaan antibiotik yang bijak dan rasional.

3.11.2. SMF Obgyn

Tabel 23. Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuanlitatif pada SMF Obgyn

No	Kriteria Gyssens	Standar	Bulan		
			Januari (%)	Februari (%)	Maret (%)
1	Kategori 0	≥ 50	100	100	100
2	Kategori 1	0	0	0	0
3	Kategori 2A	0	0	0	0
4	Kategori 2B	0	0	0	0
5	Kategori 2C	0	0	0	0
6	Kategori 3A	0	0	0	0
7	Kategori 3B	0	0	0	0
8	Kategori 4A	0	0	0	0
9	Kategori 4B	0	0	0	0
10	Kategori 4C	0	0	0	0
11	Kategori 4D	0	0	0	0
12	Kategori 5	0	0	0	0

Analisis :

Pada SMF Obgyn hanya terdapat kategori 0 yang menunjukkan penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase kategori 0 pada SMF Obgyn yaitu 100 % disetiap bulannya.

Rencana tindak lanjut :

Pada SMF Obgyn, persentase Gyssens kategori 0 sudah mencapai 100%, maka perlu dipertahankan.

3.11.3. SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung

Tabel 24. Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuanlitatif pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung

No	Kriteria Gyssens	Standar	Bulan		
			Januari (%)	Februari (%)	Maret (%)
1	Kategori 0	≥ 50	26,67	25	28,57
2	Kategori 1	0	0	0	0
3	Kategori 2A	0	0	0	0
4	Kategori 2B	0	0	0	0
5	Kategori 2C	0	6,67	0	0
6	Kategori 3A	0	0	0	0

7	Kategori 3B	0	13,33	16,67	42,85
8	Kategori 4A	0	6,67	25	14,28
9	Kategori 4B	0	0	0	0
10	Kategori 4C	0	20	25	14,28
11	Kategori 4D	0	6,67	0	0
12	Kategori 5	0	20	8,33	0

Analisis ;

1. Pada triwulan I terdapat kategori 0 yaitu penggunaan antibiotik tepat dan rasional, namun dari ketiga bulan tersebut, persentasenya masih belum memenuhi standar.
2. Pada triwulan I terdapat Kategori II C sebesar 6,67% dibulan Januari yang menunjukkan pemberian antibiotik tidak tepat rute pemberiannya.
3. Kategori III B terdapat pada SMF IPD, Jantung, Paru, Syaraf. Prosentase tertinggi terdapat pada bulan Maret sebesar 42,85 % yang menunjukkan durasi pemberian antibiotik terlalu singkat
4. Kategori IV A tertinggi pada SMF IPD, Jantung, Paru, Syaraf. Prosentase tertinggi sebesar 25 % dibulan Februari yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih efektif.
5. Kategori IV D terdapat pada SMF IPD, Jantung, Paru, Syaraf sebesar 6,67 % dibulan Januari yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya.
6. Kategori V terdapat pada SMF IPD, Jantung, Paru, Syaraf sebesar 20 % dibulan Januari yang menunjukkan adanya pemberian antibiotik namun tidak ada indikasi.

Rencana tindak lanjut :

Untuk SMF IPD, Jantung, Paru, Syaraf, persentase Gyssens kategori V (Pemberian antibiotik tanpa indikasi) masih termasuk cukup tinggi. Begitu juga dengan kategori Gyssens kategori 0 (Pemberian antibiotik tepat dan rasional) yang persentasenya masih belum memenuhi standar, sehingga perlu dukungan manajemen melalui komite medis untuk melakukan supervisi dan sosialisasi terkait penggunaan antibiotik yang bijak dan rasional.

3.12. Kualitas Penggunaan Antibiotik (Gyssens) TW II

3.12.1. SMF Bedah

Tabel 25. Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuanlitatif pada SMF Bedah

No	Kriteria Gyssens	Standar	Bulan		
			Arpil (%)	Mei (%)	Juni (%)
1	Kategori 0	≥ 50	32	18	22
2	Kategori 1	0	0	0	0
3	Kategori 2A	0	0	0	0

4	Kategori 2B	0	0	0	0
5	Kategori 2C	0	0	0	0
6	Kategori 3A	0	9	6	0
7	Kategori 3B	0	14	6	0
8	Kategori 4A	0	5	24	26
9	Kategori 4B	0	0	0	0
10	Kategori 4C	0	14	24	17
11	Kategori 4D	0	23	0	4
12	Kategori 5	0	5	24	30

Analisis :

1. Pada triwulan II, terdapat kategori 0 yaitu penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase kategori 0 tertinggi pada SMF Bedah terdapat pada bulan April sebesar 32%. Namun, masih belum ada persentase dari ketiga bulan tersebut yang memenuhi standar.
2. Kategori III A tertinggi pada SMF Bedah dengan prosentase sebesar 9% dibulan April yang menunjukkan durasi pemberian antibiotik terlalu lama.
3. Kategori III B terdapat pada SMF Bedah. Prosentase tertinggi terdapat pada bulan April sebesar 14% yang menunjukkan durasi pemberian antibiotik terlalu singkat.
4. Kategori IV A tertinggi pada SMF Bedah dengan prosentase sebesar 26% dibulan Juni yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih efektif.
5. Kategori IV C paling tinggi terdapat pada SMF Bedah sebesar 24% dibulan Mei yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena terdapat antibiotik lain yang lebih murah.
6. Kategori IV D paling tinggi terdapat pada SMF Bedah sebesar 23% dibulan April yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya.
7. Kategori V terdapat pada SMF Bedah sebesar 30% dibulan Juni yang menunjukkan adanya pemberian antibiotik namun tidak ada indikasi.

Rencana tindak lanjut

Untuk SMF Bedah, persentase Gyssens kategori V (Pemberian antibiotik tanpa indikasi) masih termasuk cukup tinggi. Begitu juga dengan kategori Gyssens kategori 0 (Pemberian antibiotik tepat dan rasional) yang persentasenya masih belum memenuhi standar, sehingga perlu dukungan manajemen melalui komite medis untuk melakukan supervisi dan sosialisasi terkait penggunaan antibiotik yang bijak dan rasional.

3.12.2. SMF Obgyn

Tabel 26. Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuanlitatif pada SMF Obgyn

No	Kriteria Gyssens	Standar	Bulan		
			Arpil (%)	Mei (%)	Juni (%)
1	Kategori 0	≥ 50	100	100	100
2	Kategori 1	0	0	0	0
3	Kategori 2A	0	0	0	0
4	Kategori 2B	0	0	0	0
5	Kategori 2C	0	0	0	0
6	Kategori 3A	0	0	0	0
7	Kategori 3B	0	0	0	0
8	Kategori 4A	0	0	0	0
9	Kategori 4B	0	0	0	0
10	Kategori 4C	0	0	0	0
11	Kategori 4D	0	0	0	0
12	Kategori 5	0	0	0	0

Analisis :

Pada SMF Obgyn hanya terdapat kategori 0 yang menunjukkan penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase kategori 0 pada SMF Obgyn yaitu 100% disetiap bulannya. Hasil tersebut sudah sesuai dengan standart yaitu perolehan persentase kategori 0 ≥ 50%.

Rencana tindak lanjut :

Pada SMF Obgyn, persentase Gyssens kategori 0 sudah mencapai 100%, maka perlu dipertahankan

3.12.3. SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung

Tabel 27. Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuanlitatif pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung

No	Kriteria Gyssens	Standar	Bulan		
			Arpil (%)	Mei (%)	Juni (%)
1	Kategori 0	≥ 50	26	22	50
2	Kategori 1	0	0	0	0
3	Kategori 2A	0	0	11	17
4	Kategori 2B	0	0	0	0
5	Kategori 2C	0	0	0	0
6	Kategori 3A	0	11	11	0
7	Kategori 3B	0	21	17	0
8	Kategori 4A	0	16	11	33
9	Kategori 4B	0	5	0	0
10	Kategori 4C	0	21	22	0

11	Kategori 4D	0	0	0	0
12	Kategori 5	0	0	6	0

Analisis :

1. Pada triwulan II terdapat kategori 0 yaitu penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase kategori 0 tertinggi terdapat pada bulan Juni sebesar 50%.
2. Kategori II A terdapat pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung. Prosentase tertinggi terdapat pada bulan Juni sebesar 17% yang menunjukkan dosis pemberian antibiotik tidak tepat.
3. Kategori III A tertinggi pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung dengan prosentase sebesar 11% dibulan April dan Mei yang menunjukkan durasi pemberian antibiotik terlalu lama.
4. Kategori III B terdapat pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung. Prosentase tertinggi terdapat pada bulan April sebesar 21% yang menunjukkan durasi pemberian antibiotik terlalu singkat.
5. Kategori IV A tertinggi pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung dibulan juni dengan prosentase sebesar 33% yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih efektif.
6. Kategori IV B terdapat pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung sebesar 5% dibulan April yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya.
7. Kategori IV C paling tinggi terdapat pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung sebesar 22% dibulan Mei yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena terdapat antibiotik lain yang lebih murah.
8. Kategori V terdapat pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung sebesar 6% dibulan Mei yang menunjukkan adanya pemberian antibiotik namun tidak ada indikasi.

Rencana Tindak Lanjut :

Untuk SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung, persentase Gyssens kategori 0 (Pemberian antibiotik bijak dan rasional) pada bulan Juni telah mencapai standar. Untuk persentase Gyssens kategori V (Pemberian antibiotik tanpa indikasi) hanya terjadi pada bulan Mei dan dengan persentase yang terbilang kecil, maka perlu dipertahankan serta ditingkatkan.

3.13. Kualitas Penggunaan Antibiotik (Gyssens) TW III

3.13.1. SMF Bedah

Tabel 28. Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuanlitatif pada SMF Bedah

No	Kriteria Gyssens	Standar	Bulan		
			Juli (%)	Agustus (%)	September (%)
1	Kategori 0	≥ 50	47	39	22
2	Kategori 1	0	0	0	0
3	Kategori 2A	0	0	0	0
4	Kategori 2B	0	0	0	0

5	Kategori 2C	0	0	0	0
6	Kategori 3A	0	0	0	0
7	Kategori 3B	0	0	6	0
8	Kategori 4A	0	32	0	0
9	Kategori 4B	0	0	0	0
10	Kategori 4C	0	16	22	22
11	Kategori 4D	0	5	22	22
12	Kategori 5	0	0	11	33

- Analisis :
1. Pada triwulan III, terdapat kategori 0 yaitu penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase kategori 0 tertinggi pada SMF Bedah terdapat pada bulan Juli sebesar 47%. Namun, masih belum ada persentase dari ketiga bulan tersebut yang memenuhi standar.
 2. Kategori III B pada SMF Bedah terdapat di bulan Agustus dengan prosentase sebesar 6% yang menunjukkan durasi pemberian antibiotik terlalu singkat.
 3. Kategori IV A, ada pada bulan Juli dengan prosentase sebesar 32% yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih efektif.
 4. Kategori IV C terdapat pada SMF Bedah sebesar 22% dibulan Agustus dan September yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena terdapat antibiotik lain yang lebih murah.
 5. Kategori IV D terdapat pada SMF Bedah sebesar 22% dibulan Agustus dan September yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya.
 6. Kategori V terdapat pada SMF Bedah sebesar 33% dibulan September yang menunjukkan adanya pemberian antibiotik namun tidak ada indikasi.

Rencana tindak lanjut :

Untuk SMF Bedah, persentase Gyssens kategori V (Pemberian antibiotik tanpa indikasi) masih termasuk cukup tinggi. Begitu juga dengan kategori Gyssens kategori 0 (Pemberian antibiotik tepat dan rasional) yang persentasenya masih belum memenuhi standar, sehingga perlu dukungan manajemen melalui komite medis untuk melakukan supervisi dan sosialisasi terkait penggunaan antibiotik yang bijak dan rasional.

3.13.2. SMF Obgyn

Tabel 29. Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuanlitatif pada SMF Obgyn

No	Kriteria Gyssens	Standar	Bulan		
			Juli (%)	Agustus (%)	September (%)
1	Kategori 0	≥ 50	90	90	84
2	Kategori 1	0	0	0	0
3	Kategori 2A	0	0	0	0

4	Kategori 2B	0	0	0	0
5	Kategori 2C	0	0	0	0
6	Kategori 3A	0	0	0	0
7	Kategori 3B	0	0	0	0
8	Kategori 4A	0	10	5	5
9	Kategori 4B	0	0	0	0
10	Kategori 4C	0	0	0	0
11	Kategori 4D	0	0	5	11
12	Kategori 5	0	0	0	0

- Analisis :
1. Pada SMF Obgyn terdapat kategori 0 yang menunjukkan penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase tertinggiya 90% pada bulan Juli dan Agustus. Hasil tersebut sudah sesuai dengan standart yaitu perolehan persentase kategori 0 ≥ 50%.
 2. Kategori IV A, ada pada bulan Juli dengan prosentase sebesar 10% yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih efektif.
 3. Kategori IV D terdapat pada SMF Obgyn sebesar 11% dibulan September yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya.

Rencana tindak lanjut

Untuk SMF Obgyn, persentase Gyssens kategori 0 (Pemberian antibiotik bijak dan rasional) pada triwulan III seluruhnya telah mencapai standar. Masih terdapat beberapa kategori lain seperti kategori IV A yaitu pemilihan antibiotik yang tidak efektif, dan IV D yaitu penggunaan antibiotik yang tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya. Namun, persentasenya kecil sehingga perlu dipertahankan dan diperbaiki.

3.13.3. SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung

Tabel 30. Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuanlitatif pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung

No	Kriteria Gyssens	Standar	Bulan		
			Juli (%)	Agustus (%)	September (%)
1	Kategori 0	≥ 50	56	31	33
2	Kategori 1	0	0	0	0
3	Kategori 2A	0	0	0	0
4	Kategori 2B	0	0	0	0
5	Kategori 2C	0	0	0	0
6	Kategori 3A	0	0	0	0
7	Kategori 3B	0	0	25	27
8	Kategori 4A	0	11	6	0

9	Kategori 4B	0	0	0	0
10	Kategori 4C	0	22	31	20
11	Kategori 4D	0	11	6	20
12	Kategori 5	0	0	0	0

- Analisis :
1. Pada triwulan III, terdapat kategori 0 yaitu penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase kategori 0 tertinggi terdapat pada bulan Juli sebesar 56%.
 2. Kategori III B tertinggi pada SMF IPD, Jantung, Paru, Syaraf dengan prosentase sebesar 27% dibulan September yang menunjukkan durasi pemberian antibiotik terlalu pendek.
 3. Kategori IV A tertinggi pada SMF IPD, Jantung, Paru, Syaraf. Prosentase tertinggi sebesar 11% dibulan Juli yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih efektif.
 4. Kategori IV C paling tinggi terdapat pada SMF IPD, Jantung, Paru, Syaraf sebesar 31% dibulan Agustus yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena terdapat antibiotik lain yang lebih murah.
 5. Kategori IV D, yaitu pemilihan antibiotik yang kurang tepat karena ada antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya, terdapat prosentase yang paling tinggi yaitu 20% pada bulan September.

Rencana tindak lanjut :

Untuk SMF IPD, Jantung, Paru, Syaraf, persentase Gyssens kategori 0 (Pemberian antibiotik bijak dan rasional) pada bulan Juli telah mencapai standar. Namun tetap ada pemberian antibiotik yang masih kurang tepat, ditunjukan dengan adanya kategori lain, yaitu III B, IV A, IV C dan IV D. Sehingga tetap perlu adanya perbaikan untuk berikutnya.

3.13.4. SMF Anak

Tabel 31. Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuanlitatif pada SMF Anak

No	Kriteria Gyssens	Standar	Bulan		
			Juli (%)	Agustus (%)	September (%)
1	Kategori 0	≥ 50	36	29	27
2	Kategori 1	0	0	0	0
3	Kategori 2A	0	0	0	0
4	Kategori 2B	0	0	0	0
5	Kategori 2C	0	0	0	0
6	Kategori 3A	0	0	0	0
7	Kategori 3B	0	43	64	64
8	Kategori 4A	0	14	0	0
9	Kategori 4B	0	0	0	0
10	Kategori 4C	0	0	7	9
11	Kategori 4D	0	0	0	0

12	Kategori 5	0	7	0	0
----	------------	---	---	---	---

- Analisis :
1. Pada triwulan III, terdapat kategori 0 yaitu penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase kategori 0 tertinggi terdapat pada bulan Juli sebesar 36%.
 2. Kategori III B, dengan prosentase sebesar 64% dibulan Agustus dan September yang menunjukkan durasi pemberian antibiotik terlalu pendek
 3. Kategori IV A tertinggi pada SMF Anak dengan prosentase tertinggi sebesar 14% dibulan Juli yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih efektif.
 4. Kategori IV C paling tinggi sebesar 9% dibulan September yang menunjukkan pilihan antibiotik kurang tepat karena terdapat antibiotik lain yang lebih murah.
 5. Kategori V, yaitu pemilihan antibiotik yang kurang tepat karena tidak ada indikasi, terdapat pada bulan Juli dengan prosentase sebesar 7%.

Rencana Tindak Lanjut :

Untuk SMF Anak, persentase Gyssens kategori 0 (Pemberian antibiotik bijak dan rasional) pada triwulan III masih belum ada yang memenuhi standar. Terdapat juga pemberian antibiotik yang masih kurang tepat, ditunjukan dengan adanya kategori lain, yaitu III B, IV A, IV C dan V. Sehingga perlu adanya perbaikan untuk triwulan berikutnya.

3.14. Kualitas Penggunaan Antibiotik (Gyssens) TW IV

3.14.1. SMF Bedah

Tabel 32. Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuanlitatif pada SMF Bedah

No	Kriteria Gyssens	Standar	Bulan		
			Oktober (%)	November (%)	Desember (%)
1	Kategori 0	≥ 50	38	32	11
2	Kategori 1	0	0	0	0
3	Kategori 2A	0	0	0	0
4	Kategori 2B	0	0	0	0
5	Kategori 2C	0	0	0	0
6	Kategori 3A	0	0	0	0
7	Kategori 3B	0	0	0	0
8	Kategori 4A	0	0	0	0
9	Kategori 4B	0	0	0	0
10	Kategori 4C	0	24	11	16
11	Kategori 4D	0	5	26	37
12	Kategori 5	0	33	26	32

- Analisis :
1. Pada triwulan IV, terdapat kategori 0 yaitu penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase kategori 0 tertinggi pada SMF Bedah terdapat pada bulan Oktober

- sebesar 38%. Namun, masih belum ada persentase dari ketiga bulan tersebut yang memenuhi standar.
- Kategori III A pada SMF Bedah terdapat di bulan November dan Desember dengan prosentase sebesar 6% yang menunjukkan durasi pemberian antibiotik terlalu panjang.
 - Kategori IV C terdapat pada SMF Bedah sebesar 24% dibulan Oktober yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena terdapat antibiotik lain yang lebih murah.
 - Kategori IV D terdapat pada SMF Bedah sebesar 37% dibulan Desember yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya.
 - Kategori V terdapat pada SMF Bedah sebesar 33% dibulan Oktober yang menunjukkan adanya pemberian antibiotik namun tidak ada indikasi.

Rencana tindak lanjut

Untuk SMF Bedah, persentase Gyssens kategori V (Pemberian antibiotik tanpa indikasi) masih termasuk cukup tinggi. Begitu juga dengan kategori Gyssens kategori 0 (Pemberian antibiotik tepat dan rasional) yang persentasenya masih belum memenuhi standar, sehingga perlu dukungan manajemen melalui komite medis untuk melakukan supervisi dan sosialisasi terkait penggunaan antibiotik yang bijak dan rasional.

3.14.2. SMF Obgyn

Tabel 33. Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuanlitatif pada SMF Obgyn

No	Kriteria Gyssens	Standar	Bulan		
			Oktober (%)	November (%)	Desember (%)
1	Kategori 0	≥ 50	71	84	74
2	Kategori 1	0	0	0	0
3	Kategori 2A	0	0	0	0
4	Kategori 2B	0	0	0	0
5	Kategori 2C	0	0	0	0
6	Kategori 3A	0	0	0	0
7	Kategori 3B	0	0	0	0
8	Kategori 4A	0	19	16	26
9	Kategori 4B	0	0	0	0
10	Kategori 4C	0	0	0	0
11	Kategori 4D	0	10	0	0
12	Kategori 5	0	0	0	0

Analisis :

- Pada SMF Obgyn terdapat kategori 0 yang menunjukkan penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase tertinggiya 84% pada bulan November. Hasil tersebut

- memenuhi standart yaitu perolehan persentase kategori 0 $\geq$ 50%
- Kategori IV A, ada pada bulan Desember dengan prosentase terbesar yaitu 26% yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih efektif
 - Kategori IV D terdapat pada SMF Obgyn sebesar 10% dibulan Oktober yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya.

Rencana tindak lanjut

Untuk SMF Obgyn, persentase Gyssens kategori 0 (Pemberian antibiotik bijak dan rasional) pada triwulan IV seluruhnya telah mencapai standar. Masih terdapat beberapa kategori lain seperti kategori IV A yaitu pemilihan antibiotik yang tidak efektif, dan IV D yaitu penggunaan antibiotik yang tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya. Namun, persentasenya kecil sehingga perlu dipertahankan dan diperbaiki.

3.14.3. SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung

Tabel 34. Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuanlitatif pada SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung

No	Kriteria Gyssens	Standar	Bulan		
			Oktober (%)	November (%)	Desember (%)
1	Kategori 0	$\geq$ 50	64	82	69
2	Kategori 1	0	0	0	0
3	Kategori 2A	0	0	0	0
4	Kategori 2B	0	0	0	0
5	Kategori 2C	0	0	0	0
6	Kategori 3A	0	0	0	0
7	Kategori 3B	0	0	9	0
8	Kategori 4A	0	0	0	0
9	Kategori 4B	0	0	0	0
10	Kategori 4C	0	18	9	23
11	Kategori 4D	0	18	0	8
12	Kategori 5	0	0	0	0

Analisis :

- Pada triwulan IV, terdapat kategori 0 yaitu penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase kategori 0 tertinggi terdapat pada bulan November sebesar 82%. triwulan IV ini, ketiga bulan telah memenuhi standar yaitu kategori 0 $>$ 50%
- Kategori III B, prosentase sebesar 9% dibulan November yang menunjukkan durasi pemberian antibiotik terlalu pendek.

- Kategori IV C paling tinggi terdapat prosentase sebesar 23% dibulan Desember yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena terdapat antibiotik lain yang lebih murah.
- Kategori IV D, yaitu pemilihan antibiotik yang kurang tepat karena ada antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya, terdapat prosentase yang paling tinggi yaitu 18% pada bulan Oktober.

Rencana tindak lanjut

Untuk SMF IPD, Jantung, Paru, Syaraf, persentase Gyssens kategori 0 (Pemberian antibiotik bijak dan rasional) pada bulan November telah mencapai standar. Namun tetap ada pemberian antibiotik yang masih kurang tepat, ditunjukan dengan adanya kategori lain, yaitu III B, IV C dan IV D. Sehingga tetap perlu adanya perbaikan untuk berikutnya

3.14.4. SMF Anak

Tabel 35. Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuanlitatif pada SMF Anak

No	Kriteria Gyssens	Standar	Bulan		
			Oktober (%)	November (%)	Desember (%)
1	Kategori 0	≥ 50	33	50	54
2	Kategori 1	0	0	0	0
3	Kategori 2A	0	0	0	0
4	Kategori 2B	0	0	0	0
5	Kategori 2C	0	0	0	0
6	Kategori 3A	0	0	0	0
7	Kategori 3B	0	58	50	46
8	Kategori 4A	0	0	0	0
9	Kategori 4B	0	0	0	0
10	Kategori 4C	0	8	0	0
11	Kategori 4D	0	0	0	0
12	Kategori 5	0	0	0	0

Analisis :

- Pada triwulan IV, terdapat kategori 0 yaitu penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase kategori 0 tertinggi terdapat pada bulan Desember sebesar 54%.
- Kategori III B, dengan prosentase sebesar 58% terbesar dibulan Oktober yang menunjukkan durasi pemberian antibiotik terlalu pendek.
- Kategori IV C terdapat prosentase 8% dibulan Oktober yang menunjukkan pilihan antibiotik kurang tepat karena terdapat antibiotik lain yang lebih murah.

Rencana tindak lanjut

Untuk SMF Anak, terdapat persentase Gyssens kategori 0 (Pemberian antibiotik bijak dan rasional) dengan prosentase tertinggi 54%. Terdapat juga pemberian antibiotik yang masih kurang tepat, ditunjukkan dengan adanya kategori lain, yaitu III B, IV A, IV C dan V. Sehingga perlu adanya perbaikan untuk triwulan berikutnya

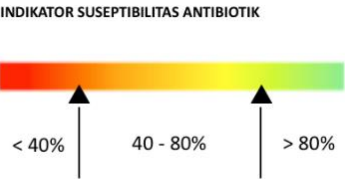
6 POLA MIKROBA DAN KEPEKAAN ANTIMIKROBA

Pola Kuman yang di ambil dari Rumah Sakit yang Mempunyai Karakteristik
Paling Mirip dengan RS. Prima Husada

8.1 Spesimen Darah – Jenis Bakteri Gram Negatif

SPESIMEN DARAH - JENIS BAKTERI GRAM NEGATIF																											
Mikroba	N	AMK	AMC	AMP	SAM	ATM	CZO	FEP	CTX	FOX	CRO	CIP	DOR	ETP	GEN	IPM	LVX	MEM	TZP	RIF	TCY	TCC	TGC	TOB	SXT	VAN	
		%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	
Acinetobacter baumannii	67	46,3	-	1,5	30,3	0	1,5	19,7	0	-	6,1	21,2	-	-	22,4	-	100	27,3	11,1	76,5	78,9	33,3	76,4	-	42,3	100	
Klebsiella pneumoniae	67	72,3	25	0	9,5	16,4	8,9	16,4	14,6	75	16,4	44,4	100	63,5	26,9	100	75	65,7	39,6	69,2	57,1	33,3	73,7	25	41	100	
Escherichia coli	28	100	100	14,8	29,2	58,3	16,7	58,3	59,1	100	53,6	60	100	95,8	81,5	100	25	96,4	90,5	42,9	87,5	0	87,5	100	60	87,5	
Enterobacter cloacae	54	84,6	0	0	0	15,4	0	30,8	10	0	14,3	100	100	69,2	35,7	100	100	71,4	63,6	0	33,3	-	66,7	0	42,9	100	
Catatan: (-) = Antik																											

Data primer PDS R
Catatan: (-) = Antibiotik tidak digunakan

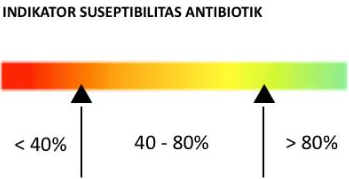


8.2. Spesimen Darah – Jenis Bakteri Gram Positif

SPEKIMEN DARAH - JENIS BAKTERI GRAM POSITIF

SXT	VAN	CHL
%S	%S	%S
50,4	95,8	-
50,6	88	-
40	100	-
44,8	66,7	100
53,3	100	-
33,3	100	-
53,3	100	-
58,8	100	-
45,5	100	-

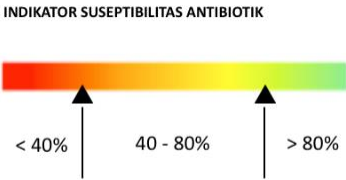
Data primer PDS PatKLIn
Catatan: (-) = Antibiotik tidak diujikan



8.3 Spesimen Sputum – Jenis Bakteri Gram Negatif

SPESIMEN SPUTUM - JENIS BAKTERI GRAM NEGATIF																												
Mikroba	N	AMK	AMC	AMP	SAM	ATM	CZO	FEP	CTX	FOX	CPO	CRO	CXM	CIP	DOR	DOX	ETP	GEN	IPM	LVX	MEM	OFX	TZP	TCY	TGC	TOB	SXT	CHL
		%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S
Acinetobacter baumannii	361	34,9	0	0,6	23,8	0	0	21,3	0	0	-	5,1	-	23,8	15,4	23,1	-	27,7	21,4	25	21,4	0	20,6	55,7	75,4	53,8	45,2	0
Klebsiella pneumoniae	279	82,4	50	0,7	26,3	23,6	4,8	25,5	24	81,2	50	26,5	100	47	91,7	83,3	67,5	54,2	81,2	76,2	69,2	33,3	48,8	46,4	76,4	75	41,2	62,5
Pseudomonas aeruginosa	185	61,2	0	0,6	3,5	26	0	56,3	0	0	-	0	-	47,7	33,3	0	-	49,4	14,3	37,5	42,5	100	33,5	44,7	84,3	83,3	52,7	-
Escherichia coli	45	93,2	80	2,3	15,4	5,1	0	7,7	11,1	60	-	8,9	-	17,5	100	20	84,6	52,3	100	33,3	86,7	0	57,1	54,5	79,4	60	51,4	-
Enterobacter cloacae	42	90,2	0	2,5	6,1	45,5	0	63,6	36,1	14,3	0	41,5	-	82,4	71,4	57,1	72,7	67,5	71,4	50	80,5	50	64,9	16,7	79,3	14,3	46,4	0
Data primer	PDS	PatK	Lin																									
Stenotrophomonas maltophilia	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,5	-	-	-	16,7	62,5	-	72	-

Data primer PDS PatKLin
Catatan: (-) = Antibiotik tidak diujikan

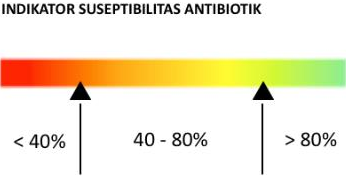


8.4 Spesimen Sputum – Jenis Bakteri Gram Positif

SPESIMEN SPUTUM - JENIS BAKTERI GRAM POSITIF

GC	SXT	VAN	CHL
%S	%S	%S	%S
76	39,3	70	100
5,7	56,2	25	-
1,7	60	54,5	100
0	88,9	-	

Data primer PDS PatKLIn
Catatan: (-) = Antibiotik tidak diujikan

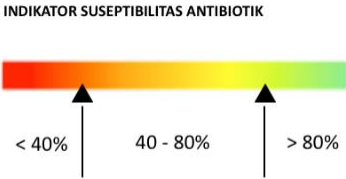


8.5 Spesimen Urine – Jenis Bakteri Gram Negatif

SPESIMEN URINE - JENIS BAKTERI GRAM NEGATIF																									
No	Mikroba	N	AMK	AMC	AMP	SAM	ATM	CZO	FEP	FOX	CRO	CIP	ETP	FOS	GEN	IPM	LVX	MEM	OFX	TZP	TCY	TCC	TGC	SXT	
			%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S
1	<i>Escherichia coli</i>	200	97,4	60,9	12,2	19,9	52,3	33,1	51,8	57,1	50,8	41,3	97,4	100	75,1	93,8	21,2	96,4	43,8	70	57,9	66,7	69,4	32,9	
2	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	82	93,6	0	0	22,1	29,3	18,8	31,2	0	28,8	48,7	89,3	100	63,3	100	33,3	91,5	100	55,4	58,3	0	83,9	38,7	
3	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	20	65	0	0	0	31,2	0	61,1	0	0	44,4	-	100	38,9	33,3	33,3	61,1	0	62,5	20	0	83,3	54,5	
4	<i>Proteus mirabilis</i>	16	100	60	28,6	50	44,4	16,7	33,3	50	50	80	55,6	100	76,9	0	80	66,7	0	58,3	-	0	50	50	
5	<i>Enterobacter cloacae</i>	16	100	0	0	0	53,8	0	76,9	0	43,8	92,3	76,9	-	81,2	100	100	87,5	-	53,8	50	0	83,3	66,7	
6	<i>Acinetobacter baumannii</i>	15	66,7	0	0	50	0	0	35,7	0	0	28,6	-	-	53,3	0	0	46,7	-	44,4	0	0	62,5	42,9	

Data primer PDS PatKLIn

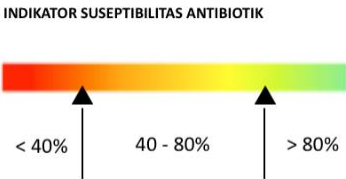
Catatan: (-) = Antibiotik tidak diujikan



8.6 Spesimen Urine – Jenis Bakteri Gram Positif

SPESIMEN URINE - JENIS BAKTERI GRAM POSITIF																															
No	Mikroba	N	AMK	AMX	AMC	AMP	SAM	FEP	CTX	CRO	CIP	CLI	DOX	GEN	IPM	LVX	LNZ	NIT	OFX	OXA	TZP	RIF	TCY	TGC	SXT	VAN	CXM	CEP	HAP	CED	CLR
			%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S
1	<i>Staphylococcus haemolyticus</i>	44	88,9	2,8	2,8	0	3,2	3	5,7	3,1	42,3	18,8	100	53,6	3,7	38,2	85,7	97,1	44,4	2,7	5,6	25	57,1	100	57,1	45,5	3,4	3,7	3,7	3,7	38,5
2	<i>Enterococcus faecalis</i>	24	0	78,9	76,2	76,2	78,9	0	0	-	27,8	0	100	-	80	33,3	91,7	90,9	-	-	76,5	0	10	76,9	33,3	80	-	-	-	-	-

Data primer PDS PatKLIn
Catatan: (-) = Antibiotik tidak diujikan

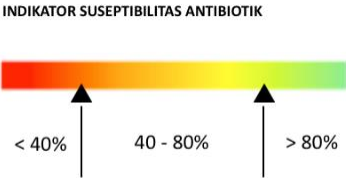


8.7 Spesimen Pus – Jenis Bakteri Gram Negatif

SPESIMEN PUS - JENIS BAKTERI GRAM NEGATIF																						
No	Mikroba	N	AMK	AMX	AMC	AMP	SAM	FEP	CTX	FOX	CRO	CIP	ETP	GEN	IPM	LVX	MEM	NIT	TZP	TCY	TGC	SXT
			%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S
1	<i>Escherichia coli</i>	141	98,5	15,1	61,5	15,2	34,2	54	51,4	63,6	51,4	43,1	97,5	76,7	84,6	33,3	94,9	92,2	77,8	54,2	72	40
2	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	97	91,4	4,9	66,7	1,1	29,4	52,4	41,5	80	45,7	53,3	89,2	68,9	80	61,5	88,5	29,6	76,8	50	68,1	38,9
3	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	55	79,2	0	0	4,2	0	66,7	0	0	22,2	66	-	65,3	66,7	69,2	75,9	0	52	61,5	65,6	37,8
4	<i>Acinetobacter baumannii</i>	48	41,3	-	0	0	28,3	6,5	0	0	4,3	6,4	-	14,6	0	0	29,2	0	4,5	18,2	60	51,4
5	<i>Enterobacter cloacae</i>	30	89,7	0	0	0	0	48	26,9	0	27,6	50	72	51,7	66,7	50	73,3	36	36,4	83,3	66,7	57,1
6	<i>Enterobacter aerogenes</i>	13	100	0	-	0	0	33,3	12,5	-	30,8	58,3	83,3	58,3	-	-	83,3	33,3	100	25	100	42,9
7	<i>Proteus mirabilis</i>	13	100	25	-	16,7	45,5	27,3	33,3	-	33,3	33,3	63,6	36,4	-	0	66,7	0	60	75	75	50

Data primer PDS PatKLIn

Catatan: (-) = Antibiotik tidak diujikan

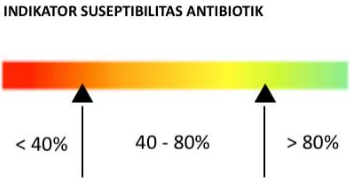


8.8 Spesimen Pus – Jenis Bakteri Gram Positif

SPESIMEN PUS - JENIS BAKTERI GRAM POSITIF																																					
No	Mikroba	N	AMK	AMX	AMC	AMP	SAM	AZM	CZO	CTX	FOX	CRO	CXM	CIP	CLR	CLI	CLO	DIC	DOR	DOX	ETP	ERY	GEN	IPM	LVX	LNZ	MEM	OFX	OXA	TZP	RIF	TCY	TCC	TGC	SXT	VAN	CHL
			%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S
1	<i>Staphylococcus aureus</i>	98	60	14,3	62,1	14,3	61,1	75,5	66,7	59,3	31	57,8	62,3	60,4	76,5	65,5	65,7	64,7	73,3	78,9	66,7	71,6	65,2	67,5	60,6	92,8	58,8	73,5	58,2	68,9	77,8	54,2	100	78,6	55,1	64,7	80
2	<i>Staphylococcus haemolyticus</i>	38	75	0	6,2	0	5,6	18,8	0	9,1	5,3	9,1	5,6	0	0	6,7	0	0	0	66,7	0	15,8	14,3	0	10,5	80,6	9,1	7,7	4,8	6,7	66,7	50	11,1	75	62,5	64,7	-
3	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	16	-	0	40	-	50	40	57,1	50	0	44,4	50	71,4	40	50	57,1	57,1	57,1	100	57,1	33,3	100	57,1	83,3	100	44,4	83,3	50	40	66,7	75	40	72,7	46,2	87,5	-
4	<i>Staphylococcus sp.</i>	13	76,9	41,7	22,2	33,3	-	45,5	-	20	36,4	0	-	50	-	50	-	-	100	-	-	18,2	-	100	30	92,3	27,3	50	28,6	38,5	-	-	0	-	66,7	100	100

Data primer PDS PatKLIn

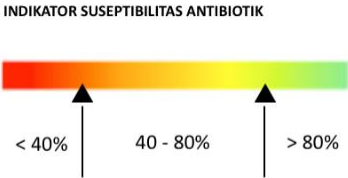
Catatan: (-) = Antibiotik tidak diujikan



8.9 Spesimen Feses – Jenis Bakteri Gram Negatif

SPESIMEN FESES - JENIS BAKTERI GRAM NEGATIF																
No	Mikroba	N	AMK	SAM	ATM	CZO	FEP	CTX	CRO	CIP	ETP	GEN	MEM	TZP	TGC	SXT
			%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S
1	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	12	100	8,3	33,3	18,2	33,3	11,1	25	58,3	91,7	75	91,7	87,5	50	25

Data primer PDS PatKLIn
Catatan: (-) = Antibiotik tidak diujikan



BAB IV.

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

1. Program kerja PPRA meliputi sosialisasi PPRA, sosialisasi penggunaan antibiotik, dan monitoring dan evaluasi penggunaan antibiotik.
 2. Dalam struktur organisasi rumah sakit, komite PPRA berada di bawah Direktur RS.
 3. Daftar dokumen yang tersedia diantaranya SK Direktur RS tentang Pembentukan Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba, Pedoman Kerja Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba, Program Kerja Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba, Panduan Penggunaan Antibiotik, dan Laporan PPRA Triwulan I, II, III dan IV. Di Rumah Sakit Prima Husada belum memiliki laboratorium mikrobiologi.
 4. Metode pengendalian pelayanan antibiotik oleh instalasi farmasi melalui surveillance penggunaan antibiotik dan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan antibiotik.
 5. Kegiatan rumah sakit untuk mendukung PPRA dengan melakukan sosialisasi tentang PPRA dan pedoman penggunaan antibiotik.
-

4.2 SARAN

1. Meningkatkan pembinaan jejaring lebih digiatkan dengan melakukan kerja sama anatar sejawat

BAB V

PENUTUP

Demikian laporan tahun 2025 Komite PPRA disusun dan disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi pelayanan kesehatan di RS Prima Husada Malang tahun 2025. Segala dukungan dan kerjasama yang diberikan dapat menunjang perbaikan pelayanan di tahun berikutnya

Malang, 10 Januari 2026

Direktur Rumah Sakit Prima Husada

dr. Resti Lestantini, M. Kes

Lampiran daftar singkatan antibiotik

Pola Kuman Yang Di Ambil Dari Rumah Sakit Yang Mempunyai Kateristik
Paling Mirip Dengan RS PRIMA HUSADA

DAFTAR SINGKATAN ANTIBIOTIK

NAMA ANTIBIOTIK	SINGKATAN	GOLONGAN ANTIBIOTIK
Amikacin	AN. AK. Ak. AMI. AMK	Aminoglycoside
Amoxicillin	AMX. Amx. AMOX. AC	Penicillin
Amoxicillin-clavulanic acid	AMC. Amc. A/C. AUG. Aug. XL. AML	Beta-Lactam/ Beta-lactamase inhibitor
Ampicillin	AM. Am. AMP X	Penicillin
Ampicillin-sulbactam	SAM. A/S. AMS. AB	Beta-Lactam/ Beta-lactamase inhibitor
Azithromycin	AZM. Azi. AZI. AZ X	Macrolide
Azlocillin	AZ. Az. AZL	Penicillin
Aztreonam	ATM. AZT. Azt. AT. AZM	Monobactam
Besifloxacin	BES	Fluoroquinolone
Carbenicillin (indanyl salt)/ Carbenicillin	CB. Cb. BAR X	Penicillin
Cefaclor	CEC. CCL. Cfr. FAC. CF	Cephem
Cefadroxil	CFR. FAD	Cephem
Cefamandole	MA. CM. Cfm. FAM	Cephem
Cefazolin	CZ. CFZ. Cfz. FAZ. KZ	Cephem
Cefdinir	CDR. Cdn. DIN. CD.CFD	Cephem
Cefditoren	CDN	Cephem
Cefepime	FEP. Cpe. PM. CPM	Cephem
Cefetamet	CAT. FET	Cephem
Cefixime	CFM. FIX. Cfe. IX X	Cephem
Cefmetazole	CMZ. CMZS. CMT	Cephem
Cefonicid	CID. Cfc. FON. CPO	Cephem
Cefoperazone	CFP. Cfp. CPZ. PER. FOP. CP	Cephem

Cefotaxime	CTX. TAX. Cft. FOT. CT	Cephem
Cefotetan	CTT. CTN. Ctn. CTE. TANS. CN	Cephem
Cefoxitin	FOX. CX. Cfx. FX	Cephem
Cefpodoxime	CPD. Cpd. POD. PX X	Cephem
Cefprozil	CPR. CPZ. FP	Cephem
Ceftaroline	CPT	Cephem
Ceftaroline-avibactam	CPA	Beta-Lactam/ Beta-lactamase inhibitor
Ceftazidime	CAZ. Caz. TAZ. TZ	Cephem
Ceftazidime-avibactam	CZA	Beta-Lactam/ Beta-lactamase inhibitor
Ceftibuten	CTB. TIB. CB X	Cephem
Ceftizoxime	ZOX. CZX. CZ. Cz. CTZ. TIZ	Cephem
Ceftobiprole	BPR	Cephem
Ceftriaxone	CRO. CTR. FRX. Cax. AXO. TX	Cephem
Cefuroxime (oral)	CXM. CFX. ROX. Crm.	Cephem
Cefuroxime (parenteral)	FUR. XM	
Cephalexin	CN. LEX. CFL X	Cephem
Cephalothin	CF. Cf. CR. CL. CEP. CE. KF	Cephem
Cephapirin	CP. HAP	Cephem
Cephradine	RAD. CH	Cephem
Chloramphenicol	C. CHL. CL X	Phenicol
Cinoxacin	CIN. Cn	Quinolone
Ciprofloxacin	CIP. Cp. CI X	Fluoroquinolone
Clarithromycin	CLR. CLM. CLA. Cla. CH	Macrolide
Clinafloxacin	CFN. CLX. LF X	Fluoroquinolone
Clindamycin	CC. CM. CD. Cd. CLI. DA X	Lincosamide
Colistin	CL. CS. CT	Lipopeptide
Dalbavancin	DAL	Glycopeptide
Daptomycin	DAP	Lipopeptide
Dicloxacillin	DX. DIC	Penicillin

Dirithromycin	DTM. DT	Macrolide
Doripenem	DOR	Carbapenem
Doxycycline	DOX. DC. DOXY	Tetracycline

Ertapenem	ETP	Carbapenem
Erythromycin	E. ERY. EM X	Macrolide
Faropenem	FAR. FARO	Penem
Fidaxomicin	FDX	Macrocyctic
Finafloxacin	FIN	Fluoroquinolone
Fleroxacin	FLE. Fle. FLX. FO	Fluoroquinolone
Fosfomycin	FOS. FF. FO. FM X	Fosfomycin
Fusidic acid	FA. FC	Steroidal
Garenoxacin	GRN	Quinolone
Gatifloxacin	GAT	Fluoroquinolone
Gemifloxacin	GEM	Fluoroquinolone
Gentamicin	GM. Gm. CN. GEN	Aminoglycoside
Gentamicin synergy	GM500. HLG. Gms	
Grepafloxacin	GRX. Grx. GRE. GP X	Fluoroquinolone
Iclaprim	ICL	Folate pathway inhibitor
Imipenem	IPM. IMI. Imp. IP	Carbapenem
Kanamycin	K. KAN. HLK. KM	Aminoglycoside
Levofloxacin	LVX. Lvx. LEV. LEVO. LE	Fluoroquinolone
Linezolid	LNZ. LZ. LZD	Oxazolidinone
Linopristin- flopristin	LFE	Streptogramin
Lomefloxacin	LOM. Lmf	Fluoroquinolone
Loracarbef	LOR. Lor. LO X	Cephem
Mecillinam	MEC	Penicillin
Meropenem	MEM. Mer. MERO. MRP. MP	Carbapenem
Methicillin	DP. MET. ME. SC	Penicillin
Metronidazole	MTZ	Nitroimidazole

Mezlocillin	MZ. Mz. MEZ	Penicillin
Minocycline	MI. MIN. Min. MN. MNO. MC. MH	Tetracycline
Moxalactam	MOX	Cephem
Moxifloxacin	MXF	Fluoroquinolone
Mupirocin	MUP. MOP. MU	Pseudomonic acid
Nafcillin	NF. NAF. Naf	Penicillin
Nalidixic acid	NA. NAL X	Quinolone
Netilmicin	NET. Nt. NC	Aminoglycoside
Nitazoxanide	NIT	Thiazolide
Nitrofurantoin	F/M. FD. Fd. FT. NIT. NI. F	Nitrofurantoin
Norfloxacin	NOR. Nxn. NX	Fluoroquinolone
Ofloxacin	OFX. OFL. Of. OF	Fluoroquinolone
Omadacycline	OMC	Tetracycline
Oritavancin	ORI	Fluoroquinolone
Oxacillin	OX. Ox. OXS. OXA X	
Penicillin	P. PEN. PV	Penicillin
Piperacillin	PIP. PI. PP. Pi	Penicillin
Piperacillin-tazobactam	TZP. PTZ. P/T. PTc	Beta-Lactam/ β -lactamase inhibitor combination
Plazomicin	PLZ	Aminoglycoside
Polymyxin B	PB	Lipopeptide
Quinupristin-dalfopristin	SYN. Syn. QDA. RP	Streptogramin
Razupenem	RZM	Carbapenem
Ramoplanin	RAM	Lipoglycopeptide
Rifampin	RA. RIF. Rif. RI. RD X	Ansamycin
Solithromycin	SOL	Fluoroketolide
Sparfloxacin	SPX. Sfx. SPA. SO X	Fluoroquinolone
Spectinomycin	SPT. SPE. SC	Aminocyclitol
Streptomycin	S. STR. StS. SM.	Aminoglycoside
Streptomycin synergy	ST2000. HLS	
Sulfonamides	SSS. S3 X	Folate pathway inhibitor
Sulopenem	SLP. SULO	Penem

Tedizolid	TED	Oxazolidinone
Teicoplanin	TEC. TPN. Tei. TEI. TP. TPL	Glycopeptide
Telavancin	TLV	Glycopeptide
Telithromycin	TEL	Ketolide
Tetracycline	TE. Te. TET. TC	Tetracycline
Ticarcillin	TIC. TC. TI. Ti	Penicillin

Ticarcillin-clavulanic acid	TIM. Tim. T/C. TCC. TLc	Beta-Lactam/β-lactamase inhibitor
Tigecycline	TGC	Glycylcycline
Tinoxanide	TIN	Thiazolide
Tinidazole	TNZ	Nitroimidazoles
Tobramycin	NN. TM. TO. To. TOB	Aminoglycoside
Trimethoprim	TMP. T. TR. W X	Folate pathway inhibitor
Trimethoprim-Sulfamethoxazole	SXT. SxT. T/S. TS. COT X	Folate pathway inhibitor
Trovafloxacin	TVA. Tva. TRV. TV X	Fluoroquinolone
Ulifloxacin (prulifloxacin)	PRU	Fluoroquinolone
Vancomycin	VA. Va. VAN X	Glycopeptide

Lembar Pengumpulan Data (LPD) Triwulan I 2025

a. Tabel data primer audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif bulan Januari 2025

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	Evani Sanchia	P/35	dr. Humaira, Sp. OG	216894	Pre Eklamsia Ringan	31/12/2024	02/01/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
2	Rifa Kumala	P/48	dr. Pradana, Sp. U	194596	Cystoscopy	02/01/2025	04/01/2025	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
3	Badariyah	P/55	dr. Ardhi, Sp. Pd	220134	DM type 2	02/01/2025	05/01/2025	4	Ceftriaxone	2	2x1	7	2	3,5
									Levofloxacin po		1x0.5	1,5	0,5	3
4	Robanah	P/64	dr. Zora, Sp. PD	224961	DM Hiperglikemi	04/01/2025	07/01/2025	4	Ciprofloxacin inf	2	2x0,2	1,4	0,8	1,75
									Asam Pipemidat		2x0,4	1,6	0,8	2,5
5	Muliani	P/68	dr. Yoga, Sp. JP	149322	Dyspnea	05/01/2025	10/01/2025	6	Ceftriaxone	2	2x1	10	2	5
									Ciprofloxacin po		2x0,5	4,5	1	4,5
6	Wahyu Aris	L/27	dr. Zaki, Sp. B	225127	Hemoroid	06/01/2025	08/01/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
7	Supiani	P/44	dr. Aida, Sp. OG	223418	PRM	07/01/2025	09/01/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67

									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
8	Supriyadi	L/46	dr. Anton, Sp.B	212029	Necrotizing fasciitis	07/01/2025	09/01/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftizoxime		3x1	6	4	1,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	0,75
9	Suliana	P/34	dr. Anton, Sp.B	199917	Necrotizing fasciitis	14/01/2025	16/01/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	5	2	2.5
									Metronidazole po		3x0,25	0,75	2	0,375
10	Rara Ayu	P/29	dr. Aida, Sp.OG	156799	SC	16/01/2025	18/01/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
11	Musringatun	P/46	dr. Zaki, Sp.B	095948	Susp appendicitis acute	15/01/2025	19/01/2025	5	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	7	2	3,5
12	Paeri	L/63	dr. Ardhany, Sp. Pd	225648	Systemic inflammatory	15/01/2025	18/01/2025	4	Levofloxacin inf	1	1x0,5	1,5	0,5	3
13	Desi Ayu	P/29	dr. Humaira, Sp.OG	217065	SC	17/01/2025	19/01/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
14	Sulasmini	P/57	dr. Ira, Sp.JP	225708		17/01/2025	20/01/2025	4	Azitromycin	2	1x0,5	1	0,3	3,33

					Angina Pectoris				Cefixime po		2x0,1	0,4	0,4	1
15	Paini	P/58	dr. Zaki, Sp.B	213310	Cholangitis ikterik	17/01/2025	19/01/2025	3	Ciprofloxacin inf	2	2x0,2	0,8	0,8	1
									Metronidazole inf		3x0,5	3	1,5	2
16	Suryanto	L/61	dr. Farid, Sp. U	201834	CVA	18/01/2025	21/01/2025	3	Azitromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
17	Tjong Sui Lan	P/69	dr. Ardhi, Sp.Pd	174685	Colic Abdomen	19/01/2025	26/01/2025	8	Ceftiaxone	2	2x1	3	2	1,5
									Cefoperazone		2x1	8	4	2
18	Atim	P/63	dr. Zaky, Sp.B	064323	Gangren daibeticum	21/01/2025	25/01/2025	5	Ceftriaxone	3	2x1	7	2	3.5
									Cefoperazone		1x2	2	4	0.5
									Metronidazole inf		3x0,5	3,5	1,5	2,33
19	Ngadi	L/72	dr. Elvi, Sp.P	225992	Dyspnea	22/01/2025	25/01/2025	4	Ceftriaxone	3	2x1	3	2	1,5
									Levofloxacin inf		1x0,75	2,25	0,5	4,5
									Asam Ppipemidat		2x0,4	2	0,8	2,5
20	Kustinah D	P/50	dr. Heri, Sp.Pd	225997	DM type 2	22/01/2025	26/01/2025	5	Ceftiaxone	2	2x1	9	2	4,5

									Asam Pipemidat		2x0,4	3,6	0,8	4,5
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	-------	-----	-----	-----

b. Tabel data primer audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif bulan Februari 2025

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	Santoso	L/59	dr. Yoga, Sp.JP	226229	Syok Kardiogenik	27/01/2025	02/02/2025	7	Ceftriaxone	2	2x1	14	2	7
									Levofloxacin po		1x0,5	3,5	0,5	7
2	Muslica	P/64	dr. Zaki, Sp. B	226256	Necrotizing facitis	28/01/2025	02/02/2025	5	Ceftriaxone	2	2x1	9	2	4,5
									Metronidazole inf		3x0,5	5,5	1,5	3,67
3	M Ifham C	L/66	dr. Anton, Sp.B	226468	Ganggren Diabetic	01/02/2025	03/02/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,25	2	0,625
4	Mudjayanah	P/61	dr. Heri, Sp.Pd	226249	DM type 2	01/02/2025	05/02/2025	5	Ceftiaxone	2	2x1	9	2	4,5
									Asam Pipemidat		2x0,4	2,4	0,8	3
5	Ani Ati	P/63	dr. Heri, Sp.Pd	217025	OF	02/02/2025	05/02/2025	4	Ceftriaxone	2	2x1	6	2	3
									Metronidazole inf		2x0,5	3	1,5	2
6	Munjiono	L/45	dr. Anton, Sp.B	226500		03/02/2025	05/02/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5

					Necrotizing fasciitis				Ceftriaxone		3x1	5	2	2,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	0,75
7	Tasu'in	L/67	dr. Ardhany, Sp. Pd	226683	Malaise and fatigue	04/02/2025	06/02/2025	3	Levofloxacin inf	1	1x0,5	1	0,5	2
8	Ponimi	P/68	dr. Zaki, Sp.Pd	226831	Post of Amputasi	07/02/2025	09/02/2025	3	Ceftriaxone	2	2x1	4	2	2
									Metronidazole inf		3x0,5	4,5	1,5	3
9	Nabilla I	P/25	dr. Ardhany, Sp.Pd	221471	Diarrhoea	07/02/2025	10/02/2025	4	Asam Pipemidat	2	2x0,4	2	8	2,5
									Cefixime		2x0,1	1	0,4	2,5
10	Sukardi	L/74	dr. Andy, Sp. P	200612	COPD, HT	08/02/2025	13/02/2025	6	Azitromycin po	1	1x0,5	2,5	0,3	8,3
11	Wahyu Saskya	P/23	dr. Aida, Sp.OG	227002	SC	10/02/2025	12/02/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
12	Shofi'i K	L/64	dr. Zaki, Sp.B	227077	Gangrene	11/02/2025	13/02/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
13	Chrismi Ismawati	P/24	dr. Humaira, Sp.OG	227058	Preamture repture	11/02/2025	13/02/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1

14	Wiwik Indrayani	P/32	dr. Andi, Sp.B	226390	Abses Mamae Dextra	13/02/2025	16/02/2025	4	Ceftriaxone	2	2x1	6	2	3
									Metronidazole inf		3x0,5	4,5	1,5	3
15	Wartani	L/65	dr. Anton, Sp.B	186975	Appendicitis pedis	19/02/2025	22/02/2025	4	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	7	2	3.5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
16	Sri Mardiana	P/59	dr. Ira, Sp. Jp	113462	ADHF, Susp Pneumoni	20/02/2025	24/02/2025	5	Azitromycin po	1	1x0,5	1,5	0,3	5
17	Yossy Dwi	P/28	dr. Heri, Sp.Pd	227564	TF	22/02/2025	28/02/2025	7	Ceftriaxone	2	2x1	5	2	2,5
									Asam Pipemidat		2x0,4	2,4	0,8	3
18	Ratnawati	P/40	dr. Humaira, Sp.OG	227676	PEB	24/02/2025	26/02/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
19	Tumiasih	P/46	dr. Zaki, Sp.B	211797	Hemoroid	24/02/2025	27/02/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
20	Rosati	P/51	dr. Pradana, Sp. U	067107	Observation for susp malignant	25/02/2025	27/02/2025	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5

c. Tabel data primer audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif bulan Maret 2025

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	M Sueb	L/57	dr. Heri, Sp.Pd	227934	OF H-8	01/03/2025	07/03/2025	7	Levofloxacin po	2	1x0,75	5,25	0,5	10,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
2	Sanusi	L/72	dr. Andy, Sp.P	197323	Dyspnea	03/03/2025	07/03/2025	3	Azitromycin po	3	1x0,5	1	0,3	3,33
									Meropenem		2x1	6	3	2
									Levofloxacin inf		3x0,25	1,5	0,5	3
3	Anam Jumadi	L/44	dr. Aji, Sp.Pd	123986	Enchelophathy	09/03/2025	10/03/2025	2	Metronidazole inf	2	4x0,5	3,5	1,5	2,33
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
4	David Adi	L/23	dr. Zaki, Sp.B	093671	COS 345	10/03/2025	13/03/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	6	2	3
5	Friska Mey	P/27	dr. Humaira, Sp.OG	225378	Gravida SC	11/03/2025	13/03/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
6	Edis Adelia	P/16	dr. Aida, Sp.OG	228456	SC	11/03/2025	13/03/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1

7	Revalino T	L/26	dr. Arianto, Sp.OT	103388	CF Patela	11/03/2025	14/03/2025	4	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
8	Muhammad Noer	L/21	dr. Farid, Sp. N	049242	Chronic intractable pain	11/03/2025	15/03/2025	5	Clindamycin	1	4x0,6	7,2	1,2	6
9	Siti Mukhayana	P/55	dr. Ardhany, Sp. Pd	222081	Vomiting ec urenia	12/03/2025	15/03/2025	4	Levofloxacin	1	1x0,5	0,5	0,5	1
10	Silviana C	P/29	dr. Humaira, Sp.OG	228119	Floating Head	14/03/2025	16/03/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
11	Yohana S	P/46	dr. Ardhany, Sp. Pd	228595	CKD stage 2	14/03/2025	16/03/2025	3	Levofloxacin inf	1	1x0,5	1,5	0,5	3
12	Irwan Rahman	L/38	dr. Anton, Sp.B	150624	Hidrocel testis	14/03/2025	16/03/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	7	2	3,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
13	Kasnawi	L/70	dr. Ardhi, Sp.Pd	024214	DM + Hidronefrosis renal	15/03/2025	19/03/2025	5	Ceftriaxone	2	2x1	8	2	4
									Asam Pipemidat		2x0.4	1,6	0,8	2,5
14	Nisviyatul Amri	P/46	dr. Oka, Sp.OT	093688	Flexor Tenosynovitis	16/03/2025	18/03/2025	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5

15	Ruminah	P/64	dr. Arianto, Sp.OT	228665	Ruptur tendon flexor	16/03/2025	18/03/2025	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
16	M Mukhlis	L/62	dr. Aji, Sp. Pd	228666	Chronic diarrhea	16/03/2025	20/03/2025	5	Ciprofloxacin po	1	2x0,5	3,5	1	3,5
17	M Firmansyah	L/25	dr. Pradana, Sp. U	045530	Strictur Uretra	18/03/2025	20/03/2025	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
18	Sudarsih	L/75	dr. Pradana, Sp. U	088276	Susp Nefroliasis	26/03/2025	29/03/2025	4	Gentamycin	1	2x0,04	0,28	0,24	1,167
19	Nurul Yaqin	L/58	dr. Anton, Sp.B	166085	Gangren anogenital	28/03/2025	30/03/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
20	Anggelina K	P/20	dr. Sigit, Sp. BP	229132	Injury of unspecified	28/03/2025	30/03/2025	3	Cefazolin	1	2x1	6	3	2

Lembar Pengumpulan Data (LPD) Triwulan II 2025

a. Tabel data primer audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif bulan April 2025

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	Nadiya F	P/27	dr.Aji, Sp.Pd	212900	TF	01/04/2025	03/04/2025	3	Azitromycin po	1	1x0,5	1,5	0,3	5
2	Titik Rustanti	P/60	dr. Zora, Sp.BP	159231	DM Hiperglikemi	03/04/2025	06/04/2025	4	Ciprofloxacin inf	2	2x0,2	0,8	0,8	1
									Ciprofloxacin po		2x0,5	2	1	2
3	Kunainah	P/44	dr. Ardhi, Sp.Pd	212694	General Weaknes + DM	05/04/2025	09/04/2025	5	Asam Pipemidate	2	2x0,4	3,2	0,8	4
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
4	Indy Belva A	P/18	dr. Sigit, Sp.BP	229437	CKR 456	06/04/2025	09/04/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
5	Sri Asnanik	P/68	dr. Yoga, Sp.JP	224631	Chest pain	07/04/2025	11/04/2025	5	Ceftriaxone	2	2x1	10	2	5
									Ciprofloxacin inf		1x0,4	1,6	0,8	2
6	Isman Hadi	L/42	dr. Zaky, Sp.B	228110		08/04/2025	10/04/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5

					Hernia Ingunalis (S)				Ceftriaxone		2x1	4	2	2
7	Askur	L/72	dr. Heri, Sp. Pd	229547	DM Hiperglikemi	09/04/2025	11/04/2025	3	Ceftriaxone	1	2x1	5	2	2,5
8	Moch Dja’far	L/49	dr. Elvi, Sp. P	229771	Hemaptoe	13/04/2025	15/04/2025	3	Ceftriaxone	1	2x1	3	2	1,5
9	Ninik Farida	P/53	dr. Anton, Sp.B	087303	CKR 456	13/04/2025	15/04/2025	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
10	Chindi M	P/30	dr. Aida, Sp.OG	075162	SC Eracs	14/04/2025	16/04/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
11	Parto	L/65	dr.Ardhany, Sp. Pd	229814	CKD st V + Pneumoni	14/04/2025	17/04/2025	4	Levofloxacin inj	1	1x0,5	1,5	0,5	3
12	Purnomo Edi	L/73	dr. Anton, Sp.B	162566	Gangren necrotic diabeticum	15/04/2025	17/04/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	4	2	2
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
13	Faizatul K	P/27	dr. Aida, Sp.OG	065799	SC	15/04/2025	18/04/2025	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
14	Hadi Mulyo	L/43	dr. Arianto, Sp.B	056807		15/04/2025	17/04/2025	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1

					Fracture of other parts				Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
15	Suramah	P/64	dr.Ardhany, Sp. Pd	229894	DM Type 2	16/04/2025	20/04/2025	5	Levofloxacin inj	1	1x0,5	2,5	0,5	5
16	Sutiani	P/57	dr.Zora, Sp. Pd	178669	Gastroenteritis	17/04/2025	20/04/2025	4	Ciprofloxacin inf	1	2x0,2	1,4	0,8	1,75
17	Nofi C	P/42	dr. Zora, Sp.Pd	172291	TF	20/04/2025	24/04/2025	4	Levofloxacin po	2	1x0,5	1,5	0,5	3
									Levofloxacin inj		1x0,5	1	0,5	2
18	Anggi Annur	P/24	dr. Anton, Sp.B	230259	Necrotizing facitis coli	23/04/2025	25/04/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	4	2	2
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
19	Moch Ridwan	L/60	dr. Yoga, Sp.JP	182365	DM krisis hiperglikemi, ALO	23/04/2025	28/04/2025	6	Levofloxacin po	2	1x0,5	2	0,5	4
									Ceftriaxone		2x1	11	2	5,5
20	Jumanah	P/71	dr. Ardhany, Sp.Pd	230369	CHF	25/04/2025	28/04/2025	4	Levofloxacin inj	1	1x0,5	1,5	0,5	3

b. Tabel data primer audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif bulan Mei 2025

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	Rubi'ati	P/61	dr. Heri, Sp.Pd	204084	DM Type 2	04/05/2025	07/05/2025	4	Levofloxacin po	2	1x0,75	3	0,5	6
									Metronidazole inf		2x0,5	4	1,5	2,67
2	Kasiati	P/49	dr. Humaira, Sp.OG	203066	Endometriosis	06/05/2025	08/05/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
3	Ainun Ulumi	P/22	dr. Aida, Sp.OG	206805	SC	08/05/2025	10/05/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
4	Ida Rahmawati	P/27	dr. Aida, Sp.OG	071885	SC	09/05/2025	11/05/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
5	Santoso	L/80	dr. Mira, Sp.JP	081276	Heart Failure	10/05/2025	13/05/2025	4	Asam Pipemidate	2	2x0,4	3,2	0,8	4
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2
6	Ari Anita	P/36	dr. Andi, Sp.BP	231095	Necrotizing Fascitis	12/05/2025	15/05/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Cefoperazone		2x1	4	4	1
7	Muchlis Hanafi	L/62	dr. Ardhi, Sp.Pd	186772	OF	13/05/2025	15/05/2025	3	Levofloxacin po	2	1x0,5	1	0,5	2

									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
8	Elisabet G	P/27	dr. Ard hany, Sp.Pd	231152	TF	14/05/2025	18/05/2025	4	Levofloxacin po	2	1x0,5	1,5	0,5	3
									Levofloxacin inj		1x0,5	1,5	0,5	3
9	Sri Widodo	P/62	dr. Ard hany, Sp.Pd	058182	TF	15/05/2025	18/05/2025	4	Levofloxacin po	2	1x0,5	1	0,5	2
									Levofloxacin inj		1x0,5	1,5	0,5	3
10	Badriyah	P/61	dr. Anton, Sp.B	116956	Necrotizing Fascitis	16/05/2025	18/05/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
11	Titus Sukriwani	L/64	dr.Ard hany, Sp. Pd	229894	DM Type 2	17/05/2025	21/05/2025	5	Levofloxacin inj	1	1x0,5	2,5	0,5	5
12	Catur Priyo	L/31	dr. Ardhi, Sp. Pd	231309	Febris	19/05/2025	22/05/2025	4	Ciprofloxacin po	1	2x0,5	3,5	1	3,5
13	Sumini	P/ 61	dr.Andy, Sp. P	143421	Hemoptysis	21/05/2025	23/05/2025	3	Azitromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
14	Adi Sumarto	L/48	dr. Oka, Sp.OT	231518	Injury of unspecified body region	21/05/2025	23/05/2025	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
15	Fikri	L/44	dr. Ardhi, Sp.Pd	231562	Cronic Fever	22/05/2025	25/05/2025	4	Ceftriaxone	2	2x1	7	2	3,5
									Levofloxacin inj		1x0,5	1,5	0,5	3
16	Siti Djumainah	P/56	dr. Zora, Sp.Pd	231203	Septic syok	22/05/2025	27/05/2025	6	Metronidazole inf	2	3x0,5	9	1,5	6

									Ceftriaxone		2x1	11	2	5,5
17	Ahmad Fikri	L/21	dr. Zaky, Sp.B	231019	Ganglion Curpi	23/05/2025	25/05/2025	3	Ceftizoxime	2	1x2	2	4	0,2
									Cefixime		2x0,1	0,4	2	3
18	Asri Ramasari	P/ 30	dr.Andy, Sp. P	201226	Atshma	24/05/2025	27/05/2025	4	Azitromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
19	Siti Rochmah	P/53	dr. Andi, Sp.B	231691	Susp Appendic	25/05/2025	28/05/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	6	2	3
20	Nurhayati	P/65	dr. Zaky, Sp.B	101888	Colic Abdomen	26/05/2025	29/05/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	6	2	3

c. Tabel data primer audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif bulan Juni 2025

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1.	Dewi Agung	P/46	dr. Zaki, Sp.B	155781	Gangrenen	03/06/2025	04/06/2025	2	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
2.	HJ. Praptini	P/69	dr. Ira, Sp.JP	223270	ALO	04/06/2025	07/06/2025	4	Levofloxacin inf	2	1x0,5	0,5	0,5	1
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
3.	Syafa Nabila	P/16	dr. Anton, Sp. B	232241	Abdominal pain	06/06/2025	09/06/2025	4	Ceftriaxone	1	2x1	8	2	4
4.	Tasmi	P/85	dr. Zaki, Sp.B	232263	Hemoroid	07/06/2025	08/06/2025	2	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,57
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
5.	Sa'i	L/65	dr. Andi A, Sp. B	232330	Carcinoma thyroid	08/06/2025	11/06/2025	4	Cefoperazone	1	2x1	6	4	1,5
6.	Tri Agustinayanti	P/34	dr. Ardhi, Sp.Pd	232331	TF	08/06/2025	11/06/2025	4	Asam Pipemidate	2	2x0,4	1,6	0,8	2
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2
7.	Asniwati	P/61	dr. Ardhan, Sp.Pd	232373	Cholelithiasis	09/06/2025	12/06/2025	4	Levofloxacin inf	2	1x0,5	1	0,5	2
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
8.	Mutmainah	P/82	dr. Ira, Sp.JP	232361	Ventricular premature	09/06/2025	11/06/2025	3	Ceftriaxone	2	2x1	4	2	2
									Azitromycin		1x0,5	1,5	0,3	5
9.	Misri	L/41	dr. Yoga, Sp.JP	206726	NSTEMI	09/06/2025	12/06/2025	4	Levofloxacin inf	2	1x0,75	1,5	0,5	3
									Ceftriaxone		2x1	7	2	3,5
10.	Nike Chusnul	P/30	dr. Humaira, Sp.OG	214788	SC Eracs	10/06/2025	12/06/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1

11.	Nasrul Ilham M	L/25	dr. Pradana, Sp. U	175034	Hydronephrosis	10/06/2025	12/06/2025	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
12.	Erista Yustiana	P/28	dr. Humaira, Sp. OG	224330	SC Eracs	10/06/2025	12/06/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
13.	Ngatoko	L/68	dr. Elvi, Sp. P	232410	Pulmonary Hypertension	10/06/2025	15/06/2025	6	Cefadroxile	2	2x0,5	2	2	1
14.	Solicha	P/28	dr. Farid, Sp. N	135511	Stroke	13/06/2025	17/06/2025	5	Ceftriaxone	2	2x1	2	2	1
15.	Clarisa Venta	P/25	dr. Zaki, Sp. B	199240	Neoplasm of breast	17/06/2025	19/06/2025	3	Meropenem	2	2x1	7	3	2,3
16.	Sri Ari Bawaning	P/62	dr. Elvi, Sp. P	217237	Asthma	20/06/2025	24/06/2025	5	Levofloxacin inf	2	1x0,5	1,5	0,5	3
17.	Harwati H	P/70	dr. Mira, Sp. JP	180211	Syok condition	21/06/2025	26/06/2025	6	Ceftriaxone	2	2x1	8	2	4
18.	Isnaniyah	P/60	dr. Zaki, Sp. B	211220	Gangren Necrotic	22/06/2025	24/06/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,57
19.	Endang Tri	P/54	dr. Zaki, Sp. B	227974	Diabetic foot	22/06/2025	24/06/2025	3	Ceftriaxone	3	2x1	2	2	1
20.	Latifatul Z	P/23	dr. Aida, Sp. OG	232991	Premature	22/06/2025	24/06/2025	3	Ceftriaxone	2	2x1	5	2	2,5
									Azitromycin	2	1x0,5	1,5	0,3	5
									Cefoperazone	1	3x1	14	4	3,5
									Cefoperazone	3	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone	3	2x1	3	2	1,5
									Metronidazole inf	3	3x0,5	1,5	1,5	1
									Cefoperazone	3	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone	3	2x1	3	2	1,5
									Metronidazole inf	3	3x0,5	1,5	1,5	1
									Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile	2	2x0,5	2	2	1

Lembar Pengumpulan Data (LPD) Triwulan III 2025

a. Tabel data primer audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif bulan Juli 2025

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	Ardiansyah	L/30	dr. Arianto, Sp.OT	233336	Open wound of other of hand	30/06/2025	02/07/2025	3	Cefoperazone	2	1x1	1	4	0,25
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
2	Reva Aldo	L/29	dr. Anton, Sp.B	233308	Gangren Anogenital	30/06/2025	02/07/2025	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
3	Ni Luh Elinda	P/23	dr. Humaira, Sp.OG	162043	SC	04/07/2025	06/07/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
4	Mukiyat	L/55	dr. Ardhi, Sp.Pd	016856	TF + ISK	08/07/2025	12/07/2025	5	Ceftriaxone	2	2x1	7	2	3,5
									Asam Pipemidat		2x0.4	1,6	0,8	2,5
5	Umul Habibah	L/51	dr. Andy, Sp.P	233948	Asthma	11/07/2025	14/07/2025	4	Azithromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
6	Nadila Munip	P/23	dr. Humaira, Sp.OG	232809	Oligohydramnios	14/07/2025	16/07/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
7	Alipah	P/62	dr. Ardhanay, Sp. Pd	105460	DM	15/07/2025	19/07/2025	5	Levofloxacin inf	1	1x0,5	1,5	0,5	3
8	Ngateni	P/63	dr. Ardhi, Sp.Pd	110454	Hiperglikemi + ISK	15/07/2025	19/07/2025	5	Ceftriaxone	2	2x1	7	2	3,5

									Asam Pipemidat		2x0.4	2,4	0,8	3
9	Dullah	L/49	dr. Aji, Sp.Pd	234155	DF	16/07/2025	18/07/2025	2	Levofloxacin inf	2	1x0,75	2,25	0,5	4,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
10	Kalsum	P/72	dr. Anton, Sp.B	198907	Necrotizing facitis	21/07/2025	23/07/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	4	2	2
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
11	Musilan	L/54	dr. Fahima, SP.N	234508	CVA ICH	23/07/2025	25/07/2025	3	Cefoperazone	1	2x1	3	4	0,75
12	Marsan	L/75	dr. Ira, Sp.JP	140599	NSTEMI	23/07/2025	26/07/2025	4	Azitromycin	2	1x0,5	1,5	0,3	5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2.5
13	Artinilis	L/48	dr. Ira, Sp.JP	203877	ALO	23/07/2025	26/07/2025	4	Azitromycin	2	1x0,5	1,5	0,3	5
									Ceftriaxone		2x1	6	2	3
14	Parman	L/74	dr. Catur, Sp.P	234586	Acute Respiratory Acute	24/07/2025	27/07/2025	4	Meropenem	2	3x1	9	3	3
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
15	Samsul Arifin	L/55	dr. Anton, Sp.B	221994	Gangren necrotic diabeticum	25/07/2025	27/07/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	4	2	2
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
16	Sunardi	L/71	dr. Edi, Sp. U	198133	BPH	26/07/2025	28/07/2025	3	Cetfizoxime	1	1x2	2	4	0,5

17	You wan	L/20	dr. Sigit, Sp.BP	234721	Multiple vulnus	27/07/2025	29/07/2025	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
18	M Misbahul M	L/17	dr. Zaki, Sp.B	175470	Lymphadenopati	27/07/2025	29/07/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
19	Nengah Ratna T	P/25	dr. Humaira, Sp.OG	229454	KPD	27/07/2025	29/07/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
20	Rizky Eka	L/19	dr. Oka, Sp.OT	233174	Union Phalenx	27/07/2025	29/07/2025	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2

b. Tabel data primer audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif bulan Agustus 2025

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	Yanti Ningsih	P/26	dr. Aida, Sp.OG	162043	Pre Eklamsia	30/07/2025	01/08/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
2	Eny Zuhriah	P/63	dr. Anton, Sp.B	160878	Necrotizing facitis	01/08/2025	03/08/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1/5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
3	Kusairi	L/58	dr. Ardhany, Sp.Pd	235268	DM Hiperglikemi	06/08/2025	08/08/2025	3	Levofloxacin	1	1x0.5	1.5	0.3	5
4	Ra'im	L/73	dr. Catur, Sp. P	125436	COPD	06/08/2025	09/08/2025	4	Meropenem	1	3x1	6	3	2
5	Dasuki	L/65	dr. Andy, Sp.P	186331	COPD	07/08/2025	11/08/2025	5	Azitromycin	1	1x0.5	1.5	0.3	5
6	Hilda Dwi Vanka	P/23	dr. Humaira, Sp.OG	171684	Oligohydramnios	08/08/2025	10/08/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
7	Faradilla S	P/25	dr. Andy, Sp.P	235471	Pneumoni	10/08/2025	13/08/2025	4	Azitromycin	2	1x0.5	0.5	0.3	1.67
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
8	Patrum	L/71	dr. Pradana, Sp. U	234831	BPH	12/08/2025	14/08/2025	3	Ceftizxime	1	1x2	2	4	0.5
9	Lailatur R	P/51	dr. Andi, Sp.B	235567		12/08/2025	15/08/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5

					Hemorrhoids with complication				Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
10	Chofifa	P/53	dr. Fachriy, Sp.BS	235247	Necrotizing facitis	13/08/2025	15/08/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
11	Anang Fakhmi	L/35	Dr. Ardhi, Sp. Pd	235486	TF	13/08/2025	16/08/2025	4	Levofloxacin	1	1x1	2.25	0.3	7.5
12	Aan Trinova	L/35	dr. Zaki, Sp.B	166558	Peritonitis akut	21/08/2025	24/08/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
13	Soewarsih	P/76	dr. Heri, Sp.Pd	074832	TF + ISK	22/08/2025	25/07/2025	4	Ceftriaxone	2	2x1	7	2	3,5
									Asam Pipemidat		2x0.4	2,4	0,8	3
14	lin Budi	P/58	dr. Ardhi, Sp.Pd	001240	DM Hiperglikemi + ISK	22/08/2025	26/07/2025	5	Ceftriaxone	2	2x1	8	2	4
									Asam Pipemidat		2x0.4	2,8	0,8	3.5
15	Sulistiani	P/57	dr. Arianto, Sp.OT	172936	CF Distal	23/08/2025	25/08/2025	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1.5
16	Ririn Wijayanti	P/48	dr. Yoga, Sp.JP	066465	Dyspnea	23/08/2025	26/08/2025	2	Levofloxacin inf	2	1x0,5	1,5	0,5	3
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1

17	Ester Ningmawati	P/59	dr. Anton, Sp.B	194608	Necrotizing facitis	25/08/2025	26/08/2025	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1.5
18	Ony Devita	P/23	dr. Humaira, Sp.OG	118438	SC	26/08/2025	28/08/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
19	Tohit	L/55	dr. Aji, Sp.Pd	236147	TF + Shock Condition	26/08/2025	29/08/2025	4	Ceftriaxone	3	2x1	4	2	2
									Cefotaxime		3x1	6	4	2
									Asam Pipemidat		2x0.4	2,4	0.8	3
20	Rahit German	L/19	dr. Catur E, Sp. P	236262	Cronic fever, Efusi pleura	28/08/2025	31/08/2025	4	Ceftriaxnoe	1	2x1	6	2	3

c. Tabel data primer audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif bulan September 2025

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	Choirul Anam	L/84	dr. Edi, Sp. U	236329	BPH	01/09/2025	03/09/2025	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
2	Samsul Arifin	L/55	dr. Ardhany, Sp. Pd	221994	DM + CKD	01/09/2025	04/09/2025	4	Levofloxacin inf	1	1x0,5	2	0,3	6,67
3	Alifah	P/41	dr. Heri, Sp.Pd	200272	DM 2 + ISK	04/09/2025	09/09/2025	6	Asam Pipemidat	2	2x0,4	2,4	0,8	3
									Ceftriaxone		2x1	7	2	3,5
4	Ani Andarwati	P/31	dr. Ardhi, Sp. Pd	144918	TF	08/09/2025	10/09/2025	3	Ciprofloxacin po	1	2x0,5	2	1	2
5	Nimas Noviantika	P/25	dr. Humaira, Sp.OG	182763	Abortus	09/09/2025	10/09/2025	2	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Amoxicilin		3x0,5	1,5	1,5	1
6	Siti Meilina Dwi	P/24	dr. Humaira, Sp.OG	232752	Oligohidramnion	12/09/2025	14/09/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
7	Hermanto	L/37	dr. Zaki, Sp.B	237018	Peritonitis akut	14/09/2025	16/09/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
8	Didi Supriadi	L/82	dr. Andy, Sp. P	237027	Pneumoni PSI	14/09/2025	17/09/2025	4	Azitromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
9	Irina Kusuma P	P/24	dr. Humaira, Sp.OG	010721	KPD	16/09/2025	18/09/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67

									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
10	Hafidah	P/68	dr. Aji, Sp.Pd	237124	Cholelithiasis	16/09/2025	21/09/2025	6	Ceftriaxone	2	2x1	2	2	1
									Cefotaxime		3x1	10	4	2,5
11	Heru Suryo	L/56	dr. Pradana, Sp.U	123508	Hydrouretronefrosis osis	17/09/2025	19/09/2025	3	Ceftizoxime	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1.5
12	Amalia Iffah	P/38	dr. Anton, Sp.B	204588	Appendisitis akut	17/09/2025	20/09/2025	4	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
13	Bheny Murtopo	L/54	dr. Yoga, Sp.JP	237325	ADHF + Sepsis	20/09/2025	25/08/2025	6	Ceftriaxone	2	2x1	8	2	4
									Levofloxacin inf		1x0,5	1,5	0,3	5
14	Tatik Suprihatin	P/56	dr. Andy, Sp. P	090921	Pneumoni	21/09/2025	23/09/2025	3	Azitromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
15	Rasit	L/61	dr. Heri, Sp.Pd	237275	Abses Hepar	22/09/2025	25/09/2025	4	Ceftraixone	2	2x1	5	2	2,5
									Metronidazole inf		2x0,5	2,5	1,5	1,67
16	Melati Mandasari	P/39	dr. Ardhi, Sp.Pd	237445	ISK	23/09/2025	27/09/2025	4	Asam Pipemidat	2	2x0,4	1,6	0,8	2
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
17	Puput Pratiwi	P/18	dr. Aji, Sp. Pd	061672	Colic abdomen	23/09/2025	27/09/2025	5	Goforan (Cefotaxime)	1	2x1	8	4	2

18	Wahyundari	P/47	dr. Zaki, Sp.B	099504	Hernia Umbilical	23/09/2025	25/09/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
19	Zainul Bahri	L/53	dr. Anton, Sp.B	156453	Gangrene Necrotic Diabeticum	26/09/2025	28/09/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1/5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
20	Pudji Rahaju	P/72	dr. Oka, Sp.OT	236404	CF Distal	26/09/2025	28/09/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2

Lembar Pengumpulan Data (LPD) Triwulan IV 2025

a. Tabel data primer audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif bulan Oktober 2025

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	Asri Putri Dwi	P/27	dr. Aida, Sp.OG	068706	KPD	30/09/2025	02/10/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
2	Rizky Emiliyatus S	P/30	dr. Humaira, Sp.OG	227436	SC Eracs	02/10/2025	04/10/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
3	Rofiatun Nabila	P/21	dr. Humaira, Sp.OG	238031	Blighted ovum	06/10/2025	07/10/2025		Ceftrizxone	2	1x1	1	2	0,5
									Amoxicilin		3x0,5	1,5	1,5	1
4	Mila Dwi Pratiwi	P/27	dr. Humaira, Sp.OG	225267	Post Partum + Granuloma Vagina	07/10/2025	09/10/2025	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
5	Apriliani F	P/23	dr. Humaira, Sp.OG	234430	Oligohidramnion	08/10/2025	11/10/2025	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
6	Rosa Faradianti	P/25	dr. Humaira, Sp.OG	236389	KPD	10/10/2025	13/10/2025	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
7	Ismi Tri Utari	P/60	dr. Humaira, Sp.OG	151336	Mioma Uteri	15/10/2025	18/10/2025	4	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	`1

									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
8	Nani Suhartati	P/50	dr. Aida, Sp.OG	237867	Multiple Miomi Uteri	20/10/2025	23/10/2025	4	Cefazoline	3	1x2	2	2	1
									Metronidazole inf		3x0,5	1,5	1,5	1
									Metronidazole po		3x0,5	1,5	2	7,5
9	Inayah Kurniati	P/37	dr. Humaira, Sp.OG	84320	Abortion	22/10/2025	23/10/2025	2	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Amoxicillin		3x0,5	1,5	1,5	1
10	Anis Karunia	P/25	dr. Aida, Sp.OG	95738	SC + MOW	25/10/2025	27/10/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
11	Imam Hanafi	L/55	dr. Anton, Sp.B	238456	Selulitis dd Necrotizing Fascitis Cruris	12/10/2025	14/10/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	7	2	3.5
									Metronidazole po		3x0,25	1,75	2	0,875
12	Sulastri	P/66	dr. Edi, Sp.B	237272	Retensio urine dd cystitis	13/10/2025	15/10/2025	3	Ceftizoxime	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftizoxime		2x1	3	4	0,75
13	Nur Jamil	L/55	dr. Oka, Sp.OT	238642	Osteomyeltis pedis	15/10/2025	17/10/2025	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5

14	Mujiono	L/62	dr. Zaki, Sp.B	238637	Hernia Scrotalis	15/10/2025	17/10/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
15	Sanali	L/78	dr. Edi, Sp. U	206687	BPH	20/10/2025	22/10/2025	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
16	Supeno Hadi	L/64	dr. Anton, Sp.B	156453	Gangrene Necrotic Diabeticum Manus D	19/10/2025	21/10/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	5	2	2,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,25	2	0,625
17	Fitroir Arif	L/25	dr. Anton, Sp.B	238909	Hydrocel testis	24/10/2025	26/10/2025	3	Picyn	2	1x1,5	1,5	6	0,25
									Picyn		3x1,5	4,5	6	0,75
18	Warni	P/73	dr. Zaki, Sp.B	237911	Appendicitis akut	02/10/2025	05/10/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	6	2	3
19	Widji Asrini	P/68	dr. Andi, Sp.B	237911	Ulkus decubitus	09/10/2025	12/10/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
20	Sumirah	P/91	dr.Oka, Sp.OT	238408	CF distal radius S	11/10/2025	13/10/2025	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2

21	Djuma'ijah	P/90	dr. Andy, Sp. P	224262	COPD + Pneumoni	05/10/2025	07/10/2025	3	Ceftriaxone	1	2x1	5	2	2.5
22	Hendrik Prasetiawan	L/48	dr. Elvi, Sp.P	238132	Pneumonia, Bronkitis Kronis	06/10/2025	09/10/2025	2	Ceftriaxone	2	2x1	2	2	1
									Cefoperazone		2x1	3	4	2,5
23	Winarso	L/60	dr. Andy, Sp. P	137124	COPD Ae + Pneumoni Psi	06/10/2025	09/10/2025	4	Azitromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
24	Devan Tri Angga	L/18	Dr. Aji, Sp. Pd	238444	OF, Susp TF	11/10/2025	13/10/2025	3	Ceftriaxone	1	2x1	4	2	2
25	Sumisni	P/59	dr. Zora, Sp. Pd	238597	OF Susp DF + GEA	14/10/2025	16/10/2025	3	Ciprofloxacin po	1	2x0,5	2	1	2
26	Kiky Dwi Ratnasari	P/33	Dr. Aji, Sp. Pd	139241	Ruq pain dt cholelelitis	13/10/2025	18/10/2025	6	Ceftizoxime	1	2x1	7	2	3,5
27	Utami	P/66	Dr. Ardhi, Sp. Pd	238607	GEA + Diarrhoea	18/10/2025	19/10/2025	2	Ciprofloxacin po	1	2x0,5	2	1	2
28	Hery Sampurno	L/73	dr. Zora, Sp. Pd	062693	ISK Colic Abdomen	19/10/2025	22/10/2025	4	Ciprofloxacin po	1	2x0,5	2	1	2
29	Ruba'inah	P/65	dr. Ardhan, Sp. Pd	238794	DM Hiperkalemi + Edema Paru+ Pneumonia	19/10/2025	22/10/2025	4	Levofloxacin inf	1	1x0,5	2	0,3	6,67
30	Agus Handoyo	L/50	Dr. Yoga, Sp. Jp	131012	ADHF	21/10/2025	24/10/2025	4	Ceftrizxone	1	2x1	6	2	3

SMF ANAK

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Lab Pendukung	RF
1.	M. Amzar Athayazka	L/2 thn	dr. Dicky, Sp. A	196679	Pneumonia	01/10/2025	04/10/2025	4	Cefotaxime 3x 250 mg	-	-
2.	Maiza Adzqyra	P/ 7 bln	dr. Dicky, Sp. A	236221	TF	03/10/2025	06/10/2025	4	Goforan 3x300 mg	Igm Salmonella +4	-
3.	Enzyra Gumaisha	P/4 thn	dr. Dicky, Sp. A	238259	GEA	09/10/2025	11/10/2025	3	Cefotaxime 3x400 mg	Lekosit 14.430	-
4.	Hanifa Nuraini	P/ 16 thn	dr. Dicky, Sp.A	238373	ISK	10/10/2025	12/10/2025	3	Cefotaxime 3x1 gr	Lekosit pada urin 18.20	-
									Urotractin 2x400 mg		
5.	Jibrán Satria	L/7 thn	dr. Dicky, Sp. A	119698	BP	26/10/2025	29/10/2025	4	Cefotaxime 3x400 mg	Lekosit 18.340	
6.	Jasmine Layna	P/4 thn	dr. Fiona, Sp. A	187622	TF	20/10/2025	21/10/2025	2	Ceftriaxone 2x400 mg		Cefixime 2x2,5 ml
7.	Farel Ghaly	L/10 thn	dr. Fiona, Sp. A	239075	TF+ Diare	24/10/2025	27/10/2025	4	Ceftriaxoen 2x750 mg	Igm Salmonella +4 Lekosit 18.920	Cefixime 2x5 ml
									Cotrimoxazole 2x5 ml		
8.	M. Aqlan	L/1 thn	dr. Fiona, Sp. A	239147	BP + KDK	26/10/2025	29/10/2025	4	Ceftriaxone 2x200 mg		Cefixime 2x2,5 ml
9.	Habrizi A	L/10 bln	dr. Ratih, Sp. A	238983	Viral infection + Diare	24/10/2025	26/10/2025	3	Ceftriaxone 2x350 mg	Lekosit 2.440 Igm Salmonella +6	Cefixime 2x1

10	Zico Harun	L/6 thn	dr. Ratih, Sp. A	238915	Colic Abdomen	21/10/2025	22/10/2025	3	Ceftriaxoen 2x1 gr	Lekosit 10.810	Cefixime 2x6 ml
----	------------	---------	------------------	--------	---------------	------------	------------	---	--------------------	----------------	-----------------

b. Tabel data primer audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif bulan November 2025

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	Nabillah Hany	P/27	dr. Humaira, Sp.OG	069410	Post SC dg BSC	02/11/2025	05/11/2025	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
2	Siti Maslikah	P/48	dr. Aida, Sp.OG	239380	Post Histerektomi A/I Adenomyosis	02/11/2025	05/11/2025	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
3	Wulan Safitri M	P/31	dr. Humaira, Sp. OG	228851	Post partum	03/11/2025	04/11/2025	2	Amoxicillin	1	3x0,5	1,5	1,5	1
4	Jumrotul M	P/32	dr. Humaira, Sp.OG	238186	KPD	05/11/2025	07/11/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
5	Dita Dwi Lestari	P/26	dr. Humaira, Sp.OG	143986	Post Op Curet A/I Menometroragia	06/11/2025	07/11/2025	2	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Amoxicillin		3x0,5	1	2	0,5
6	Rina Widya R	P/32	dr. Humaira, Sp.OG	166082	Post Op Myomektomi	13/11/2025	16/11/2025	4	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
7	Intan Asih W	P/21	dr. Humaira, Sp.OG	239778		15/11/2025	17/11/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67

					Post SC A/I Oligohidramnion				Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
8	Wiwik Handayani	P/41	dr. Humaira, Sp.OG	239954	Post Histerektomi A/I Adenomyosis	17/11/2025	20/11/2025	4	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
9	Fami Wijayanti	P/40	dr. Humaira, Sp.OG	221212	SC Eracs + Riwayat PE	20/11/2025	22/11/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
10	Diana Roosita Sari	P/30	dr. Aida, Sp.OG	239572	KPD	25/11/2025	28/11/2025	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
11	Umi Kulsum	P/48	dr. Zaki, Sp.B	239289	CA Mamae Dextra Post Open Biopsi	04/11/2025	05/11/2025	2	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
12	Tan Yusuf Tanzil	L/74	dr. Edi, Sp. U	235014	BPH	08/11/2025	10/11/2025	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
13	Taseman	L/71	dr. Andi, Sp.B	196464	Necrotizing abses colli	11/11/2025	13/11/2025	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
	Choyrul Anam	L/23	dr.Oka, Sp.OT	240016		12/11/2025	14/11/2025	3	Cefazoline	2	1x1	1	3	0,33

14					CF digiti V Manus Dextra				Cefazoline		2x1	3	3	1
15	Sibai	L/63	dr. Pradana, Sp. U	123251	URS Sinitra	13/11/2025	15/11/2025	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
16	Siti Zulaikah	P/47	dr. Anton, Sp.B	185011	Necrotizing Fascitis Pedis + Anemia + AKI dd CKD	15/11/2025	17/11/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	5	2	2,5
									Metronidazole po		3x0,25	1	2	0,5
17	Hariyati	P/54	dr. Zaki, Sp.B	218898	Hemorrhoid gr 4	16/11/2025	18/11/2025	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
18	Mudriyah	P/40	dr. Anton, Sp.B	239919	TU Mamae Post Biopsi	19/11/2025	21/11/2025	3	Picyn	2	1x1,5	1,5	6	0,25
									Picyn		3x1,5	6	6	1
19	I Made Maha I	L/44	dr. Zaki, Sp.B	240462	Abses intraperitoneum post repair	23/11/2025	25/11/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
20	Rokhmatul M	P/24	dr. Sigit, Sp.BP	240585	CKR 456 + Vulnus Appertum Frontalis S	23/11/2025	25/11/2025	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2

21	Windyana	P/23	dr. Zora, Sp. Pd	138015	GEA + Vomiting	14/11/2025	16/11/2025	3	Ciprofloxacin po	1	2x0,5	2	1	2
22	Arif Mujiono	P/48	dr. Ardhi, Sp. Pd	086651	GEA	14/11/2025	16/11/2025	3	Ciprofloxacin po	1	2x0,5	2	1	2
23	Khoirul Anam	L/50	dr. Farid, Sp. N	222428	CVA Infrak + HT Emergency + Reytensi Sputum	14/11/2025	21/11/2025	8	Ceftriaxone	1	2x1	14	2	7
24	Tuty Khusniah	P/51	dr. Andy, Sp. P	109948	Pneumoni Psi + Asma ae	15/11/2025	18/11/2025	4	Ceftriaxone	1	2x1	6	2	3
25	Chusnah	P/32	dr. Aji, Sp. Pd	188107	Cholelitisias + ISK	15/11/2025	20/11/2025	6	Cefotaxime	1	2x1	10	2	5
26	M Fadlil MZ	L/71	dr. Andy, Sp. P	142289	COPD AE susp Efusi Pleura	17/11/2025	19/11/2025	3	Azitromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
27	Siti Mutmainah	P/60	dr. Aji, Sp. Pd	240505	Bacterial infection + ISK	21/11/2025	23/11/2025	3	Asam Pipemidat	2	2x0,4	2	0,8	2,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
28	Imam Syafii	L/60	dr. Ardhan, Sp. Pd	216279	Colic abdomen + Cholelitisias	23/11/2025	25/11/2025	3	Cefixime	1	2x0,2	1,2	0,4	3
29	Misnan	L/59	dr. Elvi, Sp. P	178238	COPD + Pneumonia	24/11/2025	26/11/2025	3	Ceftriaxone	1	2x1	4	2	2

30	Ignatius Loyola R	L/78	dr. Elvi, Sp. P	240708	Pneumoni PSI + ARDS + Efusi Pleura + Sepsis	25/11/2025	26/11/2025	2	Meropenem	1	2x1	2	3	0,67
----	-------------------	------	-----------------	--------	---	------------	------------	---	-----------	---	-----	---	---	------

SMF ANAK

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Lab Pendukung	RF
1.	Naura Aletta	P/4 thn	dr. Ratih, Sp. A	240094	KDK + TF	14/11/2025	16/11/2025	3	Ceftriaxone 2x 700 mg	Lekosit 26.080	Cefixime 2x1 kaps
2.	M. Agam Abizhar	L/3 thn	dr. Dicky, Sp. A	212801	TF + Diare	22/11/2025	25/11/2025	4	Cefotaxime 3x300 mg	Igm Salmonella +6	-
3.	Ibrahim Baihaqi	L/2 thn	dr. Dicky, Sp. A	193176	TF, DF	02/11/2025	04/11/2025	3	Cefotaxime 3x300 mg	Trombosit h.1 60.200 Trrombosit h.2 34.800 Trombosit h.3 30.900 Igm Salmonella +6	-
4.	Allenzio R	L/11 bln	dr. Dicky, Sp. A	225159	TF	27/11/2025	29/11/2025	3	Cefotaxime 3x250 mg	Igm Salmonella +4	-
5.	Rayyan Ahmad M	L/4 thn	dr. Dicky, Sp. A	239886	TF	10/11/2025	12/11/2025	3	Cefotaxime 3x300 mg	Igm Salmonella +6	-
6.	Anggoda Yoga	L/15 thn	dr. Fiona, Sp. A	129587	Pneumonia	26/11/2025	30/11/2025	5	Ceftriaxone 2x750 mg	Lekosit 12.770	Cefixime 2x5 ml
7.	Elvano Alvarendra	L/5 bln	dr. Fiona, Sp. A	240781	TF	27/11/2025	29/11/2025	3	Ceftriaxone 2x200 mg	Lekosit 20.150 Igm Salmonella +6	Cefixime 1,5 ml

8.	Beyza Alara	P/4 thn	dr. Fiona, Sp. A	217173	Susp Pneumoni	13/11/2025	17/11/2025	5	Ceftriaxone 2x400 mg	Thorax : BP	Cefadroxile 2x2,5 ml
9.	Yerina Andira	P/10 bln	dr. Dicky, Sp. A	223977	Pneumoni	14/11/2025	16/11/2025	3	Cefotaxime 3x300 mg	Lekosit 14.020	
10	Dafiya Mafaza	P/7 thn	dr. Ratih, Sp. A	227148	Pneumoni	13/11/2025	17/11/2025	5	Ceftriaxone 2x800 mg		

c. Tabel data primer audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif bulan Desember 2025

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	Meylinda Ayu M	P/30	dr. Humaira, Sp. OG	230471	Post SC dg KPD	04/12/2025	05/12/2025	2	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
2	Anggraini Eka P	P/33	dr. Humaira, Sp. OG	230833	Post SC A/I HT +Myoma	04/12/2025	06/12/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
3	Andi Rozita D	P/32	dr. Humaira, Sp. OG	237905	Post SC dg KPD	06/12/2025	08/12/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
4	Uswatun K	P/21	dr. Aida, Sp. OG	241091	Post SC A/I Oligohidramnion	12/12/2025	14/12/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
5	Rosida	P/39	dr. Aida, Sp. OG	241739	Post partum	16/12/2025	17/12/2025	2	Amoxicillin	1	3x0,5	1,5	1,5	1
6	Lilik Lestari W	P/38	dr. Humaira, Sp. OG	034571	Post Op Curet A/I Menometroragia + Anemia	16/12/2025	17/12/2025	2	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Amoxicillin		3x0,5	1	2	0,5
7	Hawa Miftakhul	P/30	dr. Aida, Sp. OG	240342		16/12/2025	18/12/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67

					Ruptur Kehamilan Tuba				Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
8	Izzatul Afifah	P/29	dr. Humaira, Sp. OG	085052	Post Partum IUFD + Post Kuret	20/12/2025	21/12/2025	2	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Amoxicillin		3x0,5	1,5	1,5	1
9	Nukhe Katharina	P/52	dr. Humaira, Sp. OG	126945	Myoma Uteri	22/12/2025	25/12/2025	4	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
10	Umi Latifatul	P/35	dr. Aida, Sp. OG	198981	Post SC A/I FH + KPD	23/12/2025	25/12/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
11	Ngatminah	P/51	dr. Andi, Sp.B	240237	Tumor Mamae	03/12/2025	05/12/2025	3	Ceftiaxone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
12	Edi N	L/51	dr. Oka, Sp.OT	099450	Union Metatarsal	07/12/2025	09/12/2025	3	Ceftiaxone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
13	Saprai	L/73	dr. Pradana, Sp. U	225240	Batu Ureter	09/12/2025	11/12/2025	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
14	Puji Astono	P/47	dr. Anton, Sp.B	068059		10/12/2025	12/12/2025	3	Picyn	3	1x1,5	1,5	6	0.5

					Gangrene anorectal				Picyn		3x1,5	7,5	6	1,25
									Metronidazole po		3x0,25	1,25	2	0,625
15	Untung Lelono	L/62	dr. Zaki, Sp.B	176608	Hemoroid grade IV	11/12/2025	13/12/2025	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
16	M. Adif Fahmi	L/19	dr. Anton, Sp.B	241552	Hidrocele Testis	12/12/2025	14/12/2025	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Picyn		3x1,5	3	6	0,5
17	Mariana Lenny	P/19	dr. Sigit, Sp.BP	241577	Multiple Vulnus	13/12/2025	16/12/2025	4	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
18	Samsuri	L/63	dr. Pradana, Sp. U	146857	BPH	18/12/2025	20/12/2025	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
19	Andita B	L/44	dr. Zaki, Sp.B	100776	Appendicitis akut	22/12/2025	25/12/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
20	Abdul Hamid	L/40	dr. Anton, Sp.B	242139	Hernia Scrontalis	23/12/2025	27/12/2025	5	Picyn	2	1x1,5	1,5	6	0,25
									Picyn		3x1,5	6	6	1
21	Tri Andayani	P/52	dr. Aji, Sp. Pd	240947	Cholelitis	01/12/2025	06/12/2025	6	Cefotaxime	1	3x1	11	2	5,5

22	R. B. Ruslan	L/62	dr. Elvi, Sp. P	241017	Pneumonia	02/12/2025	05/12/2025	4	Ceftriaxone	1	2x1	6	2	3
23	Haris Kistanto	L/32	dr. Ardhi, Sp.Pd	235717	Hepatomegali Peritonitis	06/12/2025	09/12/2025	3	Cefoperazone	3	1x2	2	4	0.5
									Ceftriaxone		2x1	7	2	3,5
									Metronidazole po		3x0,5	2,5	2	1,25
24	Adi Susanto	L/31	dr. Ardhi, Sp. Pd	241295	TF + Dehidrasi Ringan	08/12/2025	11/12/2025	4	Ceftriaxone	1	2x1	5	2	2,5
25	M. Usman	L/45	dr. Zora, Sp. Pd	239486	Hepatitis B + Hematemesis	08/12/2025	11/12/2025	4	Ceftriaxone	1	2x1	6	2	3
26	Farida Achmad	P/32	dr. Elvi Sp. P	241504	Bronchiectasis	11/12/2025	14/12/2025	4	Cefotaxime	1	2x1	6	2	5
27	Evi Priwanti	P/48	dr. Andy, Sp. P	221111	COPD AE	18/12/2025	22/12/2025	5	Azitromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
28	Sutarno	L/65	dr. Aji, Sp. Pd	154815	Cholelitisias	18/12/2025	22/12/2025	5	Cefotaxime	1	3x1	10	2	5
30	Galang Rochmat	L/19	dr. Heri, Sp. Pd	093250	Bacterial Infection	21/12/2025	23/12/2025	3	Levofloxacin po	1	1x0,75	2,25	0,5	4,5
29	Nurul Islam	P/54	dr. Ardhi, Sp.Pd	121582	Susp Urolitiasis	23/12/2025	25/12/2025	3	Asam Pipemidat	2	2x0,4	1,2	0,8	1,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
30	Galang Rochmat	L/19	dr. Heri, Sp. Pd	093250	Bacterial Infection	23/11/2025	25/11/2025	3	Cefixime	1	2x0,2	1,2	0,4	3

SMF ANAK

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Lab Pendukung	RF
1.	Naura Aletta	P/4 thn	dr. Ratih, Sp. A	240094	KDK + TF	14/11/2025	16/11/2025	3	Ceftriaxone 2x700 mg	Lekosit 26.080	Cefixime 2x1 kaps
1.	Fakhriyah Shanum	P/4 thn	dr. Fiona, Sp. A	172407	Pneumoni dd TB Paru	03/12/2025	07/12/2025	5	Ceftriaxone 2x400 mg OAT 3 FDC 1x2tab	Lekosit 21660 Thorax Pneumoni	Cefixime 2x2,5ml OAT 1x2tab
2.	Zevanya E	P/ 1 thn	dr. Dicky, Sp. A	241145	Pneumoni	04/12/2025	07/12/2025	4	Cefotaxime 3x300mg	Lekosit 14.510 Thorax Pneumoni	
3.	M. Zafir	L/5 bln	dr. Ratih, Sp. A	241291	BP + GEA	07/12/2025	09/12/2025	3	Ceftriaxone 2x400 mg	Lekosit 15.590 Thorax BP	Nixaven 2x2,5 ml
4.	Arunika Adeeva	P/11 thn	dr. Dicky, Sp. A	220723	GEA + Febris	07/12/2025	09/12/2025	3	Cefotaxime 3x300mg	Lekosit 11.690 Igm Salmonella +4	
5.	Jinan Daraha	P/3 thn	dr. Fiona, Sp. A	229759	TF	08/12/2025	10/12/2025	3	Ceftriaxone 2x250 mg Metronidazole tab 3x1/3	Igm Salmonella +6	Cefixime 2x2,5 ml
6.	Arkharega R	L/7 thn	dr. Fiona, Sp. A	133734	TF	10/12/2025	12/12/2025	3	Ceftriaxone 2x500 mg	Igm Salmonella +6	Cefixime 2x5 ml

7.	Sammara Shahrazad	P/8 thn	dr. Dicky, Sp. A	100411	GEA	13/12/2025	15/12/2025	3	Cefotaxime 3x400 mg Loperamid + Cotrimoxazole 2x1/4	Lekosit 15.710	
8.	Adinda Citra	P/4 thn	dr. Ratih, Sp. A	241654	KDS	14/12/2025	16/12/2025	3	Ceftriaxone 2x700 mg	Lekosit 14.620	Cefixime
9.	Jason Ibrahim	L/5 thn	dr. Dicky, Sp. A	160335	KDS	19/12/2025	21/12/2025	3	Cefotaxime 3x500 mg	Lekosit 25.120	
10.	Sayyidati F	P/ 3 thn	dr. Dicky, Sp. A	180534	Pneumonia	20/12/2025	23/12/2025	4	Cefotaxime 3x300 mg	Lekosit 10.080 Thorax Pneumonia	Cefixime 2x,5 ml

Mengetahui,

Ketua Komite PPRA



dr. Dicky Faturrachman, Sp. A., M. Biomed.

Malang 31 Januari 2026

PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M. Kes